네이처 요양병원
인증 대비 규정 요약집

인증일자 : 2026년 11월 25일
2026년 11월 27일

부 서	
이 름	

NATURE 네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

인증 조사 스케쥴

※ 200병상 이상 요양병원 (3인 2.5일)

1일차	조사위원1	조사위원2	조사위원3
13:00 ~ 14:00	조사위원 및 조사계획 소개, 의료기관 현황 발표*		
14:00 ~ 16:30	규정 및 문서검토		
16:30 ~ 17:00	조사위원 결과종합 및 논의(주요쟁점논의/조사일정조정) ※ 1일차 18시까지 연장가능		

2일차	조사위원1	조사위원2	조사위원3
08:30 – 09:30	조사계획		
09:00 ~ 11:00	환자추적조사	환자추적조사	시설 및 환경안전 시스템추적조사
11:00 ~ 12:00	의약품관리 시스템추적조사	감염관리 시스템추적조사	환자추적조사
12:00 ~ 13:00	점심식사		
13:00 ~ 14:00	환자추적조사	환자추적조사	인적자원관리 시스템추적조사
14:00 ~ 15:00	리더십 서류검토	지속적인 질 향상 시스템 추적조사	환자추적조사
15:00 ~ 16:00	리더십인터뷰		
16:00 ~ 17:00	조사위원 결과종합 및 논의(주요정잼논의/조일정조정) 병원과 3일차 일정 조정		

3일차	조사위원1	조사위원2	조사위원3
08:30 ~ 09:30	전일 결과보고 및 조사계획		
09:30 ~ 12:00	의료정보/의무기록 시스템 추적조사, 환자추적 미진한 부분		
12:00 ~ 13:00	점심식사		
13:00 ~ 15:30	(조사팀) 결과 종합 및 보고서 작성		
15:30 ~ 16:00	(조사팀장) 의료기관과 최종 조사결과 상호 확인		
16:00 ~ 17:00	총평		

*** 병원 현황, 질 향상과 환자안전 운영체계 및 질 향상 활동 사례 1개 소개**

인증평가 시 응대 및 태도 요령

1. 기본응대

가. 외모정리

-청결하고 단정한 복장(유니폼)과 머리정돈

-근무화 청결 착용

-직원 신분증 항상 패용

나. 응대방법

-조사자와 마주치는 경우 **밝은 미소**로 언제나 "안녕하십니까?"로 먼저 인사(목례)

-친절하고 자신감 있는 태도로 응대 (회피 및 거부하는 태도 삼가)

-평가자에 대한 호칭 통일 "조사위원님"

-조사위원 응대하러 오기 전 손 씻기 (손소독제 사용)

※ 조사자를 만나면 어디서건 손 위생부터 시작하라.

2. 대답 시 요령

-질문에 자신감 있고 침착하게 대답

-질문한 내용에 대해서만 간단 명료하게 담변

-다른 정보를 불필요하게 설명할 필요는 없다.

-대답 시 시간지연 된다고 다른 직원이 대답하지 않기

-조사위원 앞에서 다른 직원과 이견을 표시하지 않기

-그 자리에서 옳고 그름을 따지지 말기

※ 조사자들의 의견을 긍정적으로 받아들인다.

(조사자들의 의견이 모두 정답이지 않지만, Open Mind를 가지고 항상 수긍하는 자세를 가지고 있다는 것이 중요하다.)

3. 수검

가. 의무기록 관련 면담은 환자차트와 카덱스보면서 진행

-EMR 확인 후에는 반드시 로그아웃

나. 조사위원의 질문 의도가 이해되지 않을 때

-정중하게 되물어 질문의 의도와 내용을 명확히 파악

다. 환자 면담 요청 시 (사생활 보호 유지)

-환자에게 동의를 구하는 과정을 보일 것

라. 면담 중에 환자와 접촉할 경우도 손위생 실시

마. 본인업무와 관련 없는 질문 받은 경우 관련자에게 연락

바. 면담 중 모르는 내용 또는 기억나지 않을 경우 핸드북을 찾아보면서 대답 가능

-당황하지 않고 핸드북을 참고하거나 게시물을 이용

4. 조사과정 중 갈등 발생 시

-조사결과에 영향을 주지 않으나 권고사항인 경우에는 적극적으로 경청

-조사결과에 영향을 주는 경우 근거에 대한 설명

-조사위원이 납득하지 않은 경우 인증 준비팀으로 연락

※ 전 직원은 인증 시 조사위원과 절대로 설전을 해서는 안됩니다.

1.1 의료진간 정확한 의사소통(필수)

조사부서	전 부서
조사방법	현장관찰, 질문, 자료확인

1. 환자확인 방법

-환자이름 : "성함이 어떻게 되십니까?"환자의 이름과 등록번호 또는 생년월일을 이용하여 개방형 질문을한다.

2. 환자확인이 필요한 환자 확인 원칙과 방법

가. 정확한 환자확인 시점

- 의약품 투여 전
- 검사 시행 전(검체수집 포함)
- 진료 및 처치 전(시술포함)
- 혈액 제제 투여 전

나. 환자가 의식이 없거나 의사표현이 어려운 환자는 보호자가 있을 경우 보호자에게 확인하고 없을 경우 직원 2인이 동시에 환자인식밴드의 환자이름과 등록번호(생년월일)로 확인한다.

3. 환자인식밴드 관리

가. 환자인식밴드 착용 및 제거

-환자입원 시 원무과 직원은 환자/보호자에게 개방형 질문을 통하여 환자이름과 등록번호, 주민등록상 생년월일 정보가 일치하는가를 확인하고, 환자인식밴드를 손목에 착용시킨다.

다. 환자인식밴드의 재발급

-잘못된 정보로 인한 환자인식밴드의 오류, 훼손, 분실 시 담당간호사는 즉시 원무과에 환자인식밴드의 재발급을 의뢰하여 환자/보호자의 확인을 거쳐 착용시킨다.

4. 구두 처방 또는 전화처방

가. 구두 또는 전화처방 가능한 시점

-무균적 시술이 진행되는 경우
-심폐소생술과 같은 응급상황인 경우
-정전 또는 인터넷 장애 등 전산장애시
-한의사 당직 시

나. 구두처방 금지 의약품

-응급상황 외에는 일상적으로 사용하는 의약품만 구두처방이 가능하다.
-고위험약물(NaCl, KCL, Heparin 등), 혈액 제제, 항생제, 마약류 등의 경우 응급상황에서만 허용한다.
-백신 등은 구두처방을 허용하지 않는다.

다. 구두처방 4단계 - 구두 또는 전화처방절차에 따라 정확하게 수행한다.

-정확한 환자확인 →받아 적기 →되읽어 확인하기 →처방한 지시자가 정보의 정확성 확인하기

라. 구두처방을 낸 의사는 처방 시각으로부터 24시간 이내에 처방을 입력해야 한다.

-환자 인식 밴드가 발행되기 전, 환자인식밴드 훼손 도는 응급상황 등 환자의 의식이 없어 개방형 질문이 불가하여 환자의 생년월일이나 등록번호를 모르는 상황에서 의료진 간 환자확인을 위해 환자이름, 진단명, 환자상태 등으로 확인한다.

라. 구두처방 기록지는 구두처방 의사가 구두처방을 기록처방으로 입력한 것을 확인후 확인한 간호사는 파쇄기에 폐기한다.

5. 필요시 처방(P.R.N)

가. 필요시처방 가능 의약품 목록선정 및 관리

-필요시처방 가능 처방의 종류(의약품 목록)는 병원운영위원회에 상정하여 결정되며 매년 12월마다 주기적으로 병원운영위원회의 심의 후 결정한다.

-필요시처방 가능 의약품 목록의 변경이 필요한 경우 담당의가 필요시 처방(PRN)약물 신청서를 작성하여 약물위원회에 승인을 받는다.

-필요시처방 가능 의약품 목록 내용 : 의약품명, 적응증 등

나. 필요시 처방의 수행

-간호사는 환자의 증상을 판단한 후 각 환자의 처방에 명시된 실시기준(투여가 요구되는 환자의 상태(범위), 1회 용량, 투여경로, 최소 투여 간격, 1일 최대 투여 횟수 등)에 해당하는 경우에만 보고 없이 수행한다.

6. 혼동하기 쉬운 부정확한 처방관리 및 확인 절차

가. 부정확한 처방의 유형

-5가지 투약원칙(정확한 환자, 정확한 의약품명, 정확한 용량, 정확한 용법, 정확한 시간)중 한 가지라도 명확하지 않은 의약품 처방

-실시기준(사유)이 명시되지 않은 필요시 처방

-수기처방의 경우 알아 볼 수 없는 글씨체의 수기처방

-전자처방의 경우 의미가 명확하지 않은 처방

-유사코드, 유사발음, 유사외관, 유사 용량의 의약품 확인

나. 부정확한 처방의 대처방안

※ 혼동하기 쉬운 부정확한 처방관리 및 확인절차를 정확하게 이해하고 수행한다.

-처방 지시자에게 연락하여 확인한다.

-야간에는 당직의사에게 연락하여 확인한다.

-문의를 받은 의사는 처방한 내용을 명확히 하여 처방내용을 변경한다.

-확인되지 않은 처방은 실시하지 않으며 실시하지 못한 사유를 간호기록 또는 관련 기록지에 남긴다.

-필요한 경우 EMR 처방을 수정하거나 재입력 한다. 수정된 처방을 확인한 후에 만 투약, 조제, 검사 ,처치를 수행한다.

-의약품 보관장소 또는 보관용기, 자동포장기의 카세트 등에 새을 구분하여 유사발음(이름), 유사외관, 유사 용량 표시지를 부착한다.

1.2 낙상예방활동(필수)

조사부서	전 부서
조사방법	현장관찰, 질문, 자료확인

1. 낙상위험도 평가 도구

-모든 입원환자를 대상으로 Morse fall Scale 사정도구를 사용하여 낙상위험도를 평가한다.

2. 낙상위험도 평가 시기

가. 낙상 위험도 입원 시 초기 평가

-낙상 위험도 입원 시 초기평가는 입원 24시간 이내에 초기 평가 시행

나. 낙상 위험도 재평가

-정기적인 재평가 : 월 1회(매월 1일 Day 간호사) 시행

-비정기적인 재평가

1) 전동 시 : 인계받은 병동에서 해당 근무조가 재평가
2) 환자 상태 변화 시 : 간성 혼수, 알코올성 섬망, 발작 등이 일어났을 때 해당 근무조가 재평가
3) 낙상발생, 갑작스런 보행 장애, 혼미, 의식변화 등이 일어났을 때 해당 근무조가 재평가
4) 낙상과 관련된 의약품 투여 : 마약, 진정제, 수면제, 이뇨제 등 초기 투여한 경우 재평가

3. 낙상 위험도 평가 결과에 따른 낙상위험도 분류 기준

- 정상 : 0~ 24점
- 저위험군 : 25 ~50점
- 고위험군 51 ~ 125점

4. 낙상고위험군 환자의 낙상 예방 활동

가. 낙상 위험환자에 대한 직원 간 정보 공유 방법

-낙상위험도 평가결과에 따라 해당 환자가 낙상고위험 환자임을 관련 직원이 알 수 있도록 한다.

1) 낙상고위험군은 환자인식밴드에 '낙상고'로 표시된 빨간색 스티커 부착
2) 낙상고위험군 환자의 침상 이름표에 낙상주의 표시지 부착
3) 낙상고위험군 환자의 전자의무기록(EMR)의 낙상란에 '고'로 표시.

5. 낙상발생이 가능한 장소 또는 부서에서 낙상 예방활동 (외래, 검사실, 치료실 등)

- 환자의 이송을 포함한 이동 경로 및 외래, 검사실, 치료실 등의 낙상 발생 가능 장소 또는 부서에서 낙상예방 활동을 시행하며 낙상예방활동을 실시 후 낙상예방 활동 Check List에 기록한다.
- 다음의 환자를 낙상 고위험군으로 간주하고 주의 깊게 관찰하며

1) 보조기구를 사용하거나 보호자의 도움을 받는 등 보행 장애 및 시력장애 환자
2) 특수한 처치나 검진을 위해 처치대 또는 진찰대에 누워있거나 오르내리는 허약한 환자
3) 휠체어나 침대로 이동하는 환자
4) 환자인식밴드에 '낙상고' 빨간색 스티커 부착된 환자

1.3 손위생 수행(필수)

조사부서	전 부서
조사방법	현장관찰, 질문

1. 손위생 수행 시점

가. 환자 접촉 전

-면역저하 환자 접촉 전 : 호중구 감소증 환자(ANC 500/m^2 이하인 경우로서 감염의 위험이 있는 경우

-카테터, 튜브류가 삽입된 환자 접촉 전

나. 청결/무균 처치 전

-청결 처치 전 : 경구투약, 구강간호, 회음부 간호 등

-무균 처치 전 : 주사(정맥, 근육, 피하 등), 드레싱 카테터 삽입, 천자

다. 체액/ 분비물에 노출될 위험이 있는 행위를 하고 난 후

-검체 채취 후

-배설물이나 토물을 다룬 후

-배액관련 행위 후

-폐기물 처리 후

-오염물품 다룬 후

라. 환자 접촉 후

-격리환자 및 접촉주의, 비말주의 환자 접촉 후

-카테터, 튜브류가 삽입된 환자 접촉 후

마. 환자 주변의 기구 및 물건 접촉 후

-접촉주의 격리환자 침상 및 침상에 있는 물품 접촉 후

-환자의 체액이나 혈액, 분비물, 배설물이 오염된 환자주변 물품 접촉 후

-환자감시장치 등 주변기구 접촉 후

-환자의 산소습윤병, Suction 등 주변기구 접촉 후

2. 올바른 손 위생 수행 방법

-비누와 물 : 비누는 액체비누를 사용하며 기존 사용하던 통은 폐기후 일회용 제제를 사용한다.

-알코올제제 : 손소독제는 알코올 70% 이상 함유된 것을 사용하며 유효기간은 6개월로 정한다.

※ 올바른 손씻기 6단계 반드시 숙지

3. 올바른 손 위생 수행 방법

환자 사랑을 위한 3가지 약속

1. 정확한 시점에서 2. 올바른 방법으로 3.깨끗하게 씻어요



*** 물에 헹구고 일회용 타월로 건조 ***

(타월로 수도꼭지 잠그기)



네이처요양병원 / 감염관리실

네이처 요양병원 NATURE HOSPITAL

2.1.1 외래환자 등록 절차

조사부서	원무과
조사방법	현장관찰, 질문, 자료확인

1. 외래 등록 절차

가. 진료 예약 방법 : 방문 예약

-예약환자 진료 우선 및 진료대기시간 지연 될수 있음을 사전에 안내

-날짜가 도래하지 않은 경우 전화 또는 원무과 방문으로 변경 또는 취소 가능하며 진료 시간을 지키 않을 경우 유선으로 연락하여 진료 취소 가능에 대해 안내함

나. 외래 접수 방법 : 환자 기본정보 수집 및 등록번호 생성, 초진 및 재진 구분, 진료과 선택 안내

2. 외래 등록시 환자에게 설명해주어야 하는 정보

가. 개인정보보호 수집 및 이용 동의절차, 의료급여의뢰서 지참 안내, 진료비 확인 방법
비급여 비용 안내, 진료경유지로 진료받을 순서 안내

- 외래 환자는 진료 접수 후 진료 경유지 안내문을 통해 직원은 정확한 환자확인 실시

3. 진료 일정 및 서비스에 대한 정보 제공

가. 원무과에 비치된 진료일정 게시판을 통해 [진료과목, 진료일정, 진료의사 선택 및 외료진료가능시간] 안내

- 진료일정 게시판에는 의료진 이름, 오전 오후 구분, 요일, 진료과목, 이용안내(진료시간,점심시간,휴진)가 제공 되어야 함
- 원무과 게시된 진료일정은 원무과 직원이 관리하며 일정 변경 사항을 일정표에 반영한다.

2.1.2 입원환자 등록 절차

조사부서	원무과, 간호부
조사방법	현장관찰, 질문, 자료확인

1. 입원환자 등록절차

가. 입원 결정

-입원은 외래 진료 후 담당의의 판단 하에 입원이 결정한다.

-입원결정 후 담당의사는 치료의 목적, 계획, 예상되는 치료결과에 대해 설명하고 환자가 이에 동의하면 입원 처방 후 원무과 직원이 입원상담 후 입원수속을 진행한다.

나. 입원예약

-상담실 직원은 아래 사항일 경우 입원 예약안내문을 제공하고 귀가 시킨다.

1) 담당의와 상의 후 입원 일자가 지정되어 있는 경우

2) 환자가 원하는 병동 또는 병실이 없는 경우

-입원 당일 입원 서약서 및 추가서류를 작성하도록 안내하며 입원 예약 당일 외래 진료 종료 1시간 전까지 내원하지 않는 환자는 전화로 입원이 취소 될 수 있음을 안내한다.

다. 입원 시 확인사항 및 구비서류

-지참약이 있는 경우 지참약 및 처방전을 입원병동 간호사에게 제출하도록 안내한다.

-진료의뢰서 및 기타 의무기록, 소견서 등이 필요한 경우 원무과에 추가로 제출 하도록 안내한다.

라. 입원이 지연되는 환자관리

- 병실 부족이나 기타 사유로 입원이 지연되는 경우
- 퇴실 지연으로 인한 입원이 지연되는 경우
- 환자 본인 사정으로 입원이지연되는 경우

마. 환자 상태에 따른 관리

- 환자 상태가 중한 상태가 아닌 경우 담당의 판단하에 원무과 외래 대기 장소에서 대기
- 환자가 입원수속 마칠 때까지 대기가 아려운 경우 병동으로 먼저 입실
- 입원지연으로 환자 상태 변화가 고려될 경우 입원이 가능한 타병원으로 안내

2. 입원 순서 배정

가. 병실 배정은 입원 당일 2인 이상 입원이 있을 경우 순서 배정을 고려한다.

- 1. 입원 예약 환자 우선

2. 당일 입원 환자 순서

(1) 1순위 : 기관절개관 관리와 비위관 사용이 필요한 환자

(2) 2순위 : 비위관 사용이 필요한 환자

(3) 3순위 : 기저귀 케어, 욕창 드레싱 등이 필요한 환자

(4) 4순위 : 환자 및 보호자가 입원시간을 별도로 지정한 환자

(5) 5순위 : 그 외 환자

3. 당일 입원이 아닌 경우 입원대기 일자 관리를 위해 상담실 직원은 입원 예약 관리대장에 입원 예정일, 병동, 병실 등을 기록하고 원무과 직원은 입원 당일 환자 또는 보호자에게 입원 할 수 있도록 유선 안내한다.

3. 입원 시 정보제공

가. 원무과 직원은 규정에 따라 입원환자 등록절차를 준수하며 입원생활에 필요한 정보를 제공한다.

나. 입원 시 병실료(입원료), 상급병실료, 비급여 등에 대한 게시물로 안내하고 입원 중 세부진료비용 확인이 필요한 경우 평일 근무 시간에 문의 하도록 안내문으로 안내

다. 감염병 유행 시 보호자 상주 제한, 선제 검사 시행 등 추가안내

라. 간호사는 입원생활 안내문을 통해 필요한 정보를 제공한다.

1) 설명 내용: 면회시간, 식사시간, 담당의 회진시간, 전화사용 안내, 편의시설, 응급 시 호출 방법(간호인력 호출장치, 화장실, 비상벨 등), 병원 내 금연, 화재 시 대처방법, 감염 예방 수칙, 불만 및 고충처리, 보안주의(폭행, 도난 등), 사생활 보호 요청, 병동 안내

2.1.3 환자진료의 일관성 및 연속성 유지

조사부서	진료부, 간호부
조사방법	질문, 자료확인

1. 담당의사 변경 시 정보공유

가. 환자의 요구도에 맞는 적절한 진료의 연속성을 보장하기 위해 환자 전과 시 전과를 받는 과와 보내는 과간의 상세한 의무기록(전과기록지)으로 필요한 정보를 공유한다.

-환자의 기본정보

-투약력 및 검사결과

-인계시점에서의 환자상태 및 치료경과

-향후 치료계획

나. 책임의사 선정 및 변경 시 EMR을 통하여 변경된 정보(책임의사 이름, 회진 시간 등)를 환자 및 직원 간 공유

2. 전동

가. 전동이 이루어지는 상황

-환자가 원할 경우

-환자의 상태를 고려하여 주치의사의 전동요청이 있는 환자

-격리/역격리 환자의 1인용 이동 등 환자의 진료 요구에 따른 전동

나. 전동이 결정되면 의료진은 먼저 환자와 보호자에게 전동사유에 대해 설명한 후 카덱스 혹은 EMR(전동 기록지 등)을 통해 인수인계한다.

다. 전동이 결정되면 의료진은 먼저 환자와 보호자에게 전동사유에 대해 설명한 후 카덱스와 EMR (전동기록지 등)을 통해 인수인계한다.

-환자의 기본 정보

-환자 상태

-필요시 제공되는(제공되어야 하는) 장비 및 기구

-의료진의 동반 여부(인공호흡이 필요한 환자, 쇽이 동반된 환자, 기도폐쇄, 출혈, V/S 비정상)

-전동이 결정되면 전동 전 병동에서 원무과에 알린다

3. 근무교대 시 정보공유

-담당의사는 당직의사에게 당직일지로 환자 상태를 인계하거나 추가 정보 전달이 필요한 경우 EMR을 활용한다.

-당직의사는 담당의사에게 당직일지를 이용하여 환자상태를 인계한다.

-간호사는 근무 교대 시 카덱스를 이용하여 다음 근무 간호사에게 정보를 인수인계한다.

2.1.4 퇴원 및 전원 절차

조사부서	진료부, 간호부, 원무과
조사방법	질문, 자료확인

1. 퇴원 절차

가. 퇴원이 결정되면 환자와 보호자에게 퇴원 절차를 설명한다.

-퇴원일이 정해지면 이에 따른 준비사항에 대해 설명하고 환자(보호자) 요청 시 원무과 담당자는 예상 진료비에 대해 정보를 제공할 수 있다.

-의사의 판단이 아닌 환자 및 보호자의 요청에 의한 자의퇴원의 경우 반드시 그에 따른 위험을 설명하고, 자의퇴원서를 작성한다.

나. 퇴원 전 필요한 교육 및 정보를 제공한다.

-담당의는 퇴원전 퇴원요약지를 작성한다.

1) 퇴원 요약지 포함 내용 : 진단명, 치료 및 처치, 입원사유 및 경과요약, 퇴원 시 환자상태, 추후 관리계획 등

-병동 간호사는 퇴원 시 퇴원요약 정보의 제공을 위하여 퇴원 간호계획지를 작성하여 환자 또는 보호자에게 제공한다.

1) 퇴원 간호계획지 포함 내용 : 퇴원 시 투약설명, 주의사항, 의료기관에 문의를 요하는 증상, 가정간호 연계 필요성 여부를 포함한 추후 관리 등 을 제공한다.

2. 전원 및 의뢰 절차

가. 전원 절차

1) 전원 기관의 선정 원칙

-환자의 상태 또는 환자의 요구와 일치하는 기관의 선정

-전원 할 기관의 수용능력 확인(당일 입원 또는 입원일자 지정 후 입원 가능 여부, 본원에서 요구하는 치료 가능 여부)

2) 이송수단 및 의료진 동반의 필요성 확인

-심폐소생술을 시행한 환자가 가는 경우

-활력징후가 정상 범위를 크게 벗어나 이를 유지하기 위해 이동 중에도 의료진의 도움이나 즉각적인 처치가 필요한 경우

3) 전원 시 진료의 연속성 유지를 위해 환자의 질병상태와 치료에 대한 정보, 전원사유 등이 기재된 퇴원요약지 또는 환자의 진료정보 요약지(진료의뢰서, 의료급여회송서, 진료의뢰서), 소견서, 의무기록, 퇴원요약지 등을 의료법에 근거하여 진료정보를 제공한다.

나. 의뢰 절차

1) 타 의료기관 의뢰시 의뢰기관 관리를 위해 매년 1회 병원운영위원회에서 평가 및 선정

가) 지역 내 의료기관

나) 본원에서 요구되거나 환자 질병에 맞는 연속치료 가능 여부.

2) 의뢰 시 진료의뢰서에는 환자의 인적사항, 환자의 상태, 제공된 치료와 시술 등에 대한 내용, 전원 및 의뢰 사유에 관한 내용을 담당의사가 기록한다.

3) 응급상황 시 담당 의료진은 전원할 병원에 연락하여 진료협조를 요청한다.

4) 이송수단 및 의료진 동반의 필요성 확인한다.

-심폐소생술을 시행한 환자가 가는 경우

-활력징후가 정상 범위를 크게 벗어나 이를 유지하기 위해 이동 중에도 의료진의 도움이나 즉각적인 처치가 필요한 경우

2.2.1 외래환자 초기평가

조사부서	진료부, 원무과
조사방법	질문, 자료확인

1. 외래환자 초기평가 시기

-진료과 초진 환자 대상으로 작성한다.

2. 의학적 초기평가 시행자

-외래 진료 의사는 외래 환자의 초기 평가를 시행하고 외래 초진 기록지에 기록한다.

3. 외래 초기평가 내용

-주 호소 및 현병력
-과거력 및 가족력
-사회력
-계통 문진
-통증평가(외래 환자 통증평가로 갈음)
-신체검진
-추정진단
-치료계획

4. 타 의료기관에서 가져온 환자 정보 확인

-원무과 직원은 외래 환자의 타 병원 의뢰서 및 소견서, 검사결과지, 영상기록물 등 지참여부를 확인하고 진료의사가 진료시 평가할수 있도록 제공한다. 원무과 직원은 환자 진료 후 의뢰된 검사 결과지, 소견서 등은 의무기록 보존하기 위해 EMR에 스캔하고 환자 또는 보호자에게 돌려드린다.

2.2.2 입원환자 초기평가

조사부서	진료부, 간호부, 영양팀
조사방법	질문, 자료확인

1. 입원환자 초기평가

-의학적초기평가, 간호초기평가, 영양초기평가 시행

-의학적·간호초기평가는 환자 입원 후 **24시간** 이내 작성, 영양초기평가만 **72시간** 이내에 작성

2. 의학적 초기평가 시기

가. 의학적 초기평가 시기

-의사는 입원 24시간 이내(주말, 공휴일 포함)에 환자평가를 시행하고 입원기록지에 기록한다.

3. 간호초기평가 시기

가. 간호초기평가 시기

-간호사는 입원 24시간 이내에 환자평가를 시행하고 기록한다.

4. 영양초기평가 시기

가. 입원 시 영양사 또는 의료진(의사 또는 간호사)이 입원 후 72시간내에 영양초기평가를 시행하고 기록한다.

5. 초기평가 정보 공유(질문)

-환지진료와 관련 있는 타 부서 또는 타 직종의 직원은 필요시 해당 환자의 초기평가 기록을 의무기록 접근 권한 안에서 공유한다.

6. 입원환자 재평가

가. 의학적 재평가 대상 및 주기

- 입원일로부터 30일이 초과한 환자는 의학적 재평가 실시
- 재평가 이후 매월 1회 정기적으로 환자상태에 대해 인지 할수 있도록 경과기록에 재평가를 기록
- 전과 시 의학적 재평가 실시 후 재평가일로부터 30일 초과 후 재평가 경과기록

나. 재평가 내용

- 환자의 주호소 및 현병력
- 환자의 신체검진 결과 및 의식수준
- 치료 경과에 따른 문제
- 현재 치료계획 및 필요 시 치료계획 변경(의뢰 및 전원 포함)

다. 재평가는 EMR/OCS를 통하여 공유한다.

2.3.1 검체검사체계

조사부서	임상병리실
조사방법	질문, 자료확인

1. 검체획득 절차

가. 적절한 검체 채취용기 선택

- CBC : 혈액학적 검사(CBC, ABO&Rh, HbA1c)
  - 용기명 : EDTA-K2(보라색 용기)
  - 검체취급방법 : 혈액을 용기에 3ml 채혈하여 8~10회 정도 mix함
  - 주의사항 : 응고주의
- APTT : 응고관련검사(PT, APTT, FDP)
  - 용기명 : Sodium Citrate(파란색 용기)
  - 검체 취급방법 : 혈액 용기에 2.7ml 채혈하여 3~4회 정도 mix
  - 주의사항 : 정량채혈
- LFT : 대부분의 일반화학검사(LFT, Cross-matching)
  - 용기명 : SST(노란색 용기)
  - 검체취급방법 : 혈액을 용기에 3ml 채혈하여 3~5회 정도 혼합 후 수직으로 세워놓는다.
  - 주의사항 : 용혈주의
- 일상적 뇨 검사
  - 외부 수탁기관 검사 : 플라스틱 뚜껑이 있는 전용 Tube
  - 검체 취급 방법 : 소변은 5~6ml를 채취하며 넘치지 않도록 뚜껑을 닫는다.
- 기타 검사
  - 객담(Sputum), 대변(stool) 검체 : 객담은 깊은 기침하여 받거나 Suction하여 객담 3ml 이상 받으며 대변은 강난콩 크기(5g) 정도 채취 한다.
  - 세균배양검사 : 수송배지(Stuart Transport media)

라. 검체용기 라벨링

- 내용: 환자이름, 성별, 나이, 등록번호, 검사항목, 채취일자, 감염성질환자 붉은색 '감염' 표기
- 라벨링 시 주의사항

  가) 수혈검체에는 채혈자를 추가로 표기

마. 검사실 전달까지의 관리사항

-검사용기는 파손, 누수, 손실이 없도록 뚜껑이 있는 이동박스를 이용하여 바로 세운채로 운반한다.

-채취된 검체는 즉시 3층 검체 냉장고로 이동

-채취한 검체를 운반하는 직원은 3층 검체냉장고에 보관 시 검체 접수일, 환자이름, 병실, 등록번호 검체명을 외부 검체 검사 관리대장에 기록

2. 검사 전 검체확인절차

가. 검체적합성 확인

-검사 전 검사종류에 적합한 검체 채취용기, 검사에 필요한 채취량을 확인한다.

나. 필요 시 사전정보 확인

-검사 전 검체정보 확인 : 간호사는 검사의뢰 목적, 의뢰의사명, 검사요청일을 EMR에서 확인하여야 한다.

다. 부적합 검체 시 처리 절차

-부적합 검체

1) 환자확인을 할 수 없는 검체 (예 : 이름, 호실이 적혀있지 않은 검체, 동명이인)
2) 검체량이 부족한 경우
3) 육안으로 응고가 보인 검체
4) 육안으로 용혈되거나 지방성 검체
5) 기타검체 채취 시 주의 사항을 지키지 않은 검체

-부적합 검체 처리 지침

부적합 검체는 재 채취를 실시한다. 수탁기관으로 이송 된 검체 중 부적합 검체는 수탁기관에서 유선으로 병원으로 보고될 경우 재 채취를 실시하거나 재 채취가 불가능한 경우 접수를 취소하며 검사 처방을 취소 하고 부적합 검체 처리 대장에 기록한다.

4. 검사결과보고

종 류	정규검사	응급검사
	외부	외부
일반혈액검사	24시간 이내	12시간 이내
혈액응고검사	24시간 이내	-
요화학검사	24시간 이내	-
임상화학검사	24시간 이내	-
면역혈청검사	24시간 이내	-
미생물&배양검사	7일 이내	-

- 검사종류별 TAT 시간을 매일 기록한다.
- 정해진 TAT 의 범위를 벗어난 경우 TAT 초과 사유 대장에 기록한다.

5. 내부 정도관리

가. Critical Value Report 검사항목 선정 및 보고기준

-CVR 목록선정과 보고기준은 협의하여 병원운영위원회에 보고하여 결정한다.

CVR 기준			
검사명	**단위**	**CVR 기준**	**임상적 의의**
Hb	g/dL	7.0 미만	급성 빈혈, 활동성 출혈 (수혈 검토)
WBC	$10^3/\mu L$	1.0 미만 / 50.0 초과	중증 감염 취약(백혈구 감소) 또는 패혈증 등(백혈구 증가) 의심
Platelets	$10^3/\mu L$	50 미만	자발적 출혈 및 지혈 장애 위험
Glucose	mg/dL	50 미만 / 400 초과	급성 저혈당 쇼크 및 뇌 손상 위험 고혈당성 혼수 위기 상태
BUN	mg/dL	100 초과	중증 신부전 및 요독증 위기 (전원/투석 검토)
Creatinine	mg/dL	5.0 초과	급성 신손상(AKI) 및 신기능 급격한 악화
T.Bilirubin	mg/dL	15.0 초과	중증 간부전 및 폐쇄성 황달 위기 상태
Na (Sodium)	mmol/L	120 미만 / 160 초과	급격한 의식 저하, 뇌부종, 전신 경련 위험
K (Potassium)	mmol/L	2.8 미만 / 6.0 초과	치명적 부정맥 및 심정지 유발 (초응급)
Calcium	mg/dL	7.0 미만 / 13.0 초과	근육 마비(테타니) 및 심장 기능 정지 위험

-결과 보고 시에는 그 결과의 참고치와 함께 보고된다. 참고치를 벗어난 결과는 전산상에는 푸른색(저치) 도는 붉은색(고치)으로 표기된다.

라. 이상수치(Critical Value)발생 시 결과 확정 전 절차

- QPS전담자가 이상수치에 대해 담당의사에게 신속히 전화하여 보고하고 경고치 CVR 보고기록 표에 기재한다.
- QPS전담자 부재 시 담당 간호사가 담당의에게 보고하고 병동 업무지에 기록하고 QPS전담자는 업무복귀 시 해당 기록 근거로 경고치 CVR 보고 기록표에 기록한다.

2.3.2 영상검사체계

조사부서	방사선실, 간호부
조사방법	질문, 자료확인

1. 영상검사 전 준비사항

가. 환자준비

- 금식, 장 준비 등 전처치가 필요한 검사일 경우 해당 병동 간호사는 환자 준비를 마치고 방사선사는 환자 준비 완료 여부에 대해 해당 병동으로 유선 연락 하여 확인

나. 검사부작용 예방을 위한 확인

-가임여성은 각별히 주의 하며 X-선 검사를 해야 하는 경우 임신가능성이 있거나 임신 중이라면 반드시 검사 전 담당자에게 이야기하여 방어보호구를 착용하도록 한다.

다. 정확한 검사결과를 보장하기 위한 확인

-검사시 준비된 가운으로 갈아입히고, X-선이 투과 되지 않은 금속물질 등 제거 되었는지 확인

-복부 및 골반 촬영일 경우 이전 검사 시 조영제를 사용했다면 신장과 뇨관에 잔료 조영제가 보일 수 있으므로 담당의는 필요 시 사용여부를 확인한다.

2. 영상검사 검사결과 보고

가. 응급검사 : 촬영 후 24시간 이내 보고

나. 정규보고 : 촬영 후 72시간 이내 보고

다. EMR 영상검사 통계로 TAT 적정성 모니터링하여 분기별로 관리한다.

라. TAT 초과 시 EMR 지연사유 란에 이를 기록하고 주말 및 공휴일은 그 일수 만큼 연장한다.

3. 이상 검사 결과 보고(CVR)

가. CVR 보고기준은 진료부서와 방사선실이 협의 하여 병원운영위원회 결정.

보고 대상	보고 기준
일반촬영	1. 촬영 결과가 판독하기 어려울 정도로 선명하지 않은 경우 2. 촬영 결과에 명백한 골절이 보일 경우

나. 방사선사는 이상수치 발견시 담당의에게 유선으로 보고하고 CVR 보고 기록표에 기재한다.

4. 검사 외부 의뢰 체계

-본원은 영상검사에 대해 외부의뢰를 실시 하지 않으며 외부 검사가 필요한 경우 [3.1.2 협의진료체계]의 규정에 따라 타 의료기관으로 외부 협의 진료 절차를 실시한다.

3.1.1 입원환자 치료계획

조사부서	진료부, 간호부
조사방법	질문, 자료확인

1. 치료계획의 수립 및 재수립

가. 치료계획의 수립

나. 상태변화시 치료계획의 재 수립

-입원 시부터 치료 또는 중재를 제공하기 전에 세우며, 입원기록지에 치료 계획을 수립한다.

-환자의 상태를 평가하고, 확인된 질환과 증상을 진료기록으로 작성한다. 앞으로의 진료계획을 세우고, 향후로 있을 변화를 평가하고, 진료의 지속여부를 결정한다.

-수립된 치료계획을 제공하고, 모든 과정을 의무기록에 작성한다.

다. 환자의 주요상태 변화 시 치료계획의 재수립

-의사는 치료과정 중 특수검사 결과, 처치 및 침습적 시술 후 환자상태의 변화가 있을 시 환자평가표를 참고하여 적합한 치료계획을 재수립한다.

라. 정기적 치료계획 재수립

-환자상태 변화가 있을 시는 즉시 기록한다.

-장기입원환자는 경과에 특별한 변화가 없거나, 일정한 치료가 계속 유지되는 경우에도 최소 월 1회 이상 기록한다.

2. 간호과정

가. 간호사는 모든 입원환자 대상으로 간호문제 발생 시 간호의 과정을 DAR 과적으로 적용하여 제공한 간호의 내용을 매주 금요일 마다 기록하며 환자 상태 변화 시 마다 기록한다..

3. 치료계획 정보공유

-의무기록을 통해 치료계획 및 간호과정을 공유한다.

-환자진료와 관련된 의료진은 해당 환자의 치료계획 및 간호과정을 의무기록 접근권한 범위 안에서 공유한다.

-관련 직원은 의무기록 접근권한 범위 안에서 공유한다.

4. 환자 및 보호자에게 진료(치료계획) 관한 정보 제공

가. 진단명(또는 추정진단)

나. 치료(또는 검사) 계획의 정보 제공

다. 치료(또는 검사)에 따른 예상효과 및 위험에 대한 정보에 대해 환자 또는 보호자에게 설명 후 담당 의사는 경과기록에 기록한다.

3.1.2 협의진료 체계

조사부서	진료부
조사방법	질문, 경과기록 확인

1. 의료기관 내 타 진료과 협의 진료

가. 응급, 비응급으로 구분하여 의뢰하며 응급 의뢰인 경우 받은 진료과는 신속하게 회신한다.

나. 환자상태에 따른 응급 기준

-갑작스런 의식소실을 동반한 상태변화

-저혈압(70/70mmhg 이하), 90% 미만의 산소포화도 저하, 39.0°C이상의 고열 수일간 지속 시

다. 협의진료 회신

-협의 의뢰 받은 환자에 대하여 48시간 내에 회신하고 진료를 시행한다.

-응급의뢰인 경우 24시간 이내에 회신한다.

라. 타 의료기관 협의진료 절차

-본원에서 시행하지 않은 처치, 시술, 검사 또는 환자 상태에 따라 본원에서 진료가 어려운 타 진료과 협의가 필요한 경우 타 의료기관으로 협의 진료를 의뢰 한다.

-담당의는 진료의뢰서를 작성하고 원무과는 작성된 의뢰서를 FAX나 환자 보호자에게 전달하여 타 의료기관에 제출하도록 한다.

-타 의료기관 진료 후 협의 진료 결과(회신서 등)를 담당의는 확인 후 경과기록한다.

-확인 한 결과지는 EMR에 스캔 하여 보관한다.

-의약품 처방 받아 가지고 오는 경우 지참약으로 관리한다.

3.1.3 통증관리

조사부서	진료부, 간호부
조사방법	질문, 자료확인

1. 통증초기평가

가. 대상

- 외래 의사는 외래 초진환자 대상으로 환자가 지참한 소견서 및 진단서를 확인하여 통증을 유발하는 소견이 있거나 통증 관련 약물을 복용하거나, 문진 시 환자가 통증을 호소하는 경우 통증평가를 사정한다.

-입원 시 모든 환자를 대상으로 간호사가 통증평가도구를 이용하여 통증을 평가한다.

나. 통증의 평가내용

-통증의 유무, 위치, 강도, 양상, 빈도, 기간 등

다. 통증평가결과를 통증평가기록지에 기록한다.

2. 통증 재평가

가. 정기적 재평가

-모든 입원환자는 월 1회(매월 1일 간호사가) 재평가 실시

-마약성 진통제(경구제, 주사제, 패취제) 정기적 복용 환자 매일 1회 간호사 재평가

-통증 조절 목적 정기적 주사 처치 매일 1회 Day 간호사 재평가

나. 비정기적 재평가

-통증 양상 변화시 또는 새로운 통증 호소 하는 경우

-중등도 이상으로 의약품을 투여 했을 경우 주사제는 투약 30분 이내, 경구제 1시간, 마약성 패치제는 2시간 후 재평가

-전동 시, 침습적 시술 후 급격하게 신체상태가 악화 되었을 경우

-통증평가 종료시점은 2점 이하이다.

3. 평가도구

가. 의사소통이 가능한 경우

- 숫자 통증 척도(NRS)

-얼글통증척도(FPS)

나. 의사소통이 어려운 경우

- FLACC

3.1.4 영양관리

조사부서	영양팀
조사방법	질문, 자료확인

1. 영양상담

가. 의사

-의사는 환자의 영양적 필요와 치료계획을 기반으로 식사 처방 지침에 따라 처방 및 제공한다.

나. 영양사

-밀 라운딩(Meal Rounding)을 통하여 **환자의 식사 섭취율 및 식사관련 특이사항** 정보를 수집하고, 이에 따라 식사 처방의 변경 또는 추가 코멘트가 필요한 경우 해당주치의사에게 식사 변경에 대한 의견을 제시할 수 있다.

2. 치료식 설명

-치료식이가 처음 처방된 환자 또는 보호자에게 영양사가 환자의 영양관리를 통한 치료 효과를 높일 수 있도록 **치료식사명, 제공사유, 주의사항(음식 제한사항 등)**에 대한 치료식 식사 안내문을 제공한다.

-치료식 설명 시점은 치료식 첫 끼니를 기준으로 **72시간 이내**에 제공한다.(공휴일, 휴일제외)

-치료식 첫 끼니 이후 검사, 시술, 외출 등의 이유로 금식이 2끼니 이상 지속되는 경우는 설명하지 않으며 다시 치료식사가 시작되는 시점을 기준으로 삼는다.

3. 치료식 처방 및 제공

가. 의사는 환자의 영양적 필요와 치료계획을 기반으로 식사 처방 지침에 따라 처방 및 제공한다.

-식사처방지침이란 병원에서 제공되는 식사의 특징, 영양기준량, 식품구성 등으로 구성되어 있으며 입원환자의 처방 시 사용되며 영양관리위원회의 인준을 거친다.

-치료식은 환자의 상태와 치료목적에 맞게 의사 처방에 의해 제공해야 하며 치료식 식단 작성 지침은 식사처방 지침에 근거하여 작성하며, 식사처방 지침에 제시된 영양기준과 식품구성에 따른 식단을 작성하기 위한 방법과 권장(허용)식품 및 주의(제한)식품 등으로 구성하며 영양관리 위원회의 인준을 거친다.

나. 치료식은 환자의 상태와 치료목적에 식사처방 지침서에 근거하여 담당의사가 처방한다.

다. 영양사는 치료식 식단 작성 지침서에 따라 치료식에 대한 식단을 작성한다.

라. 제공하고 있는 치료식 :당뇨식, 저염식, 연하보조식

3. 영양상담

가. 영양상담 의뢰기준

1) 영양초기평가에서 영양상태가 불량 또는 심한불량으로 평가된 환자 중 주치의로부터 상담의뢰가 있는 경우
2) 주치의는 영양불균형, 식이섭취상태 불량 등 영양상태의 재평가가 필요하다고 판단되는 환자는 영양사에게 영양상담을 의뢰한다.

나. 영양상담 제공방법

1) 담당의로부터 영양상담 의뢰가 있을 경우 영양사는 환자에게 영양상담을 제공하며 영양상담일지를 기록한다.

다. 영양상담 기록 내용

1) 영양상담에 필요한 환자의 객관적 자료평가, 식습관 조사를 통하여 영양상담과 관련된 영양치료에 대한 계획을 수립하고 식이를 조정하거나 식이 교육 등을 실시한 후 영양 상담 일지에 내용을 기록 후 영양 상담 일지를 작성한다.
2) 작성된 영양상담일지는 EMR을 통해 담당의사와 공유한다.

3.1.5 욕창관리

조사부서	진료부, 간호부
조사방법	질문, 자료확인

1. 욕창평가도구 : Braden Scale

구분	초기평가		정기적 재평가	
	대상	시기	대상	시기
병동	모든 입원 환자	**입원 24시간이내**	모든 환자	매월 1일 Day 간호사가 시행
중재 활동	평가 점수가 12점 이하일 경우 적절한 예방활동을 수행한다. 고위험군은 check list를 이용하여 매 Duty마다 욕창예방활동 한다.			

가. 비정기적 재평가

-전동, 급격하게 신체상태가 악화되었을 경우 실시 주기와 관계없이 환자상태의 변화에 따라 즉시 시행하는 재평가

나. 욕창위험도 평가(Braden Sclae) 점수에 따른 분류

-9점 이하 : 최고위험군
-10 ~ 12점 : 고위험군
-13점 ~ 14점 : 중등도 위험군
-15 ~ 18점 : 저위험군
-19점 이상 : 비위험군

2. 욕창 발생 고위험군의 욕창예방활동 수행

-손위생을 수행한다.
-매 2시간 마다 체위변경을 시행한다.
-피부 상태를 관찰하고 항상 청결하게 유지하며 실금 및 잦은 설사 환자는 주의를 요한다.
  * 실금이나 설사로 인하여 피부에 문제가 생길 거라고 예상되는 경우 또는 생긴 경우
-필요 시 상처 제품을 사용하여 피부를 보호할 수 있다.
-침상머리는 30도 이하로 유지하며, 완전 측위보다는 30도 측위를 한다.
-베개나 매트리스를 사용하여 발꿈치나 발의 뼈 돌출부에 가해지는 압력을 제거한다.
-홑이불의 주름, 각종 라인 및 물품에 의해 환자의 피부가 눌리지 않도록 한다.
-치료상 금기사항이 아니면 충분한 수분을 섭취하도록 한다.
-필요 시 치유에 필요한 영양공급을 위한 식이를 제공한다.
-욕창발생 위험군은 인지 가능한 환자와 보호자에게 욕창예방교육을 실시한다.
-욕창을 악화시키지 않는다면 휠체어 보행을 하도록 격려하고 압력을 고려하여 30분 이내로 하도록 한다.
-수행한 욕창 예방 활동에 대하여 욕창 예방활동 체크리스트에 기록한다.

3. 욕창 발생 시 욕창 관리활동

가. 욕창평가시행 : 욕창위치, 단계, 크기(cm)를 월 1회 평가하고 기록한다.
-욕창위치 : 욕창이 생긴 환자의 신체부위를 기록한다.
-욕창단계(grade of stage) : 욕창의 침범정도 및 삼출물 등을 통하여 피부의 손상정도를 나눈다.
-욕창크기 : 가로, 세로, 깊이 의 정확한 크기를 'cm'로 기록한다.

나. 보호자에게 확인시키고 설명한다.
다. 욕창간호를 실시하고 기록한다.
라. 간호사는 욕창발생보고서를 작성하여 QPS전담자에게 보고한다.
마. 입원전 발생한 욕창은 욕창발생보고서는 제출하지 않고 간호기록만 남긴다.

3.1.6 생애말기환자 관리

조사부서	진료부, 간호부, 사회복지사
조사방법	질문, 자료확인

1. 생애말기환자 대상

-생애말기 환자란 적극적 치료에도 불구하고 점차 증상이 악화되어 담당의사 및 전문의 1명으로 부터 수개월 이내에 사망할 것으로 예상되는 진단을 받은 환자이다. [요양병원에서 임종을 앞둔 환자를 의미한다]

2. 생애말기환자 진료에 참여하는 직원의 교육 내용

-생애말기환자의 대상
-생말기환자의 주요 증상
-생애말기환자에 대한 정서적지지 방법 등 요구를 효율적으로 해소하는 방법
-생애말기환자와의 효과적인 의사소통방법
-죽음에 대한 인식
-임종 준비 및 간호방법
-존엄간호 등
-주의사항

3. 증상치료에 대하여 환자 또는 보호자에게 설명 및 치료결정에 참여 유도

-생애말기환자는 생명을 연장시키는 치료가 아닌, 고통을 받는 증상에 대한 치료가 중요하므로 환자 또는 보호자에게 증상에 대한 치료에 대해 설명하고 치료결정 시 참여시킨다.(대증치료에 대한 설명, 통증조절, 식이조절, 영적인지지 등)

4. 환자 또는 보호자에게 사회적 · 정신적지지 제공

-가족도 부정, 분노, 협상, 우울, 용납의 과정을 밟는 것을 이해하고 그것이 정상임을 이해시킨다.
-환자의 사망 후에는 상실, 사별의 현실을 수용하고 적응토록 지지해 준다.
-마음속에 있는 감정을 표현하도록 하여 여러 감정을 해소토록 지지해 준다.
-가급적 환자의 옆에서 지킬 수 있도록 지지해 주며, 무리한 상황일 경우는 쉬도록 해준다.
-가족의 급성 질환 발생은 처음 6주가 심하고 1년이 지나야 소실된다. (위장장애가 많고, 병에 대한 내성이 약해 사망률이 높아진다).
-생애말기환자는 생명을 연장시키는 치료가 아닌, 고통받는 증상에 대한 치료가 중요하므로 의료인이 환자 또는 보호자에게 증상에 대한 치료에 대해 설명하고 치료결정 시에 참여시킨다.
-의료인이 생애말기환자 또는 보호자에게 고통과 슬픔에 대한 정신·사회적지지(예시 : 환자 또는 가족에게 교육 및 상담, 위로와 격려, 따듯하고 아늑한 병실 분위기 조성, 환자 옆에서 손잡아주기, 대화 등)를 제공한다.

3. 직원의 역할

-의사 : 대증치료 처방 및 제공 / 환자 및 보호자 치료 참여 유도
-간호사 : 정신적 사회적 지지제공
-사회복지사 : [5.4 의료사회복지체계] 규정에 따라 심리사회적 상담 실시

3.1.7 결핵환자 관리

조사부서	진료부, 감염관리전담자
조사방법	질문, 자료확인

1. 결핵검진 주기 및 방법

-모든 입원 환자를 대상으로 연 1회 이상 Chest X-ray 검사를 실시한다.

-신규 입원 환자는 입원시 Chest X-ray 검사를 실시하며 입원일로부터 최근 1개월 이내 실시한 검사가 있을 경우 갈음할 수 있다.

-검사결과가 없는 환자는 입원 시점에 chset x-ray로 결핵검진을 실시한다.

2. 결핵검진 발생 시 조치 및 신고 절차

가. 결핵환자 발생 시 신고절차

-원내 결핵환자 발생 즉시 담당의는 병원장에게 보고 해야 하며 병원장은 감염관리전담자에게 원외 보고하도록 지시한다.

-감염관리전담자는 질병보건통합관리시스템에 결핵환자 발생 사실을 보고하거나 Fax 등으로 24시간 이내에 보건소에 신고한다.

나. 결핵환자 발생 시 조치

-결핵이 의심되면 7.7 감염성 질환자 관리 규정에 따라 1인실에 격리하며 보호자에게 해당 사실을 알려 치료가 가능한 병원으로 전원 및 의뢰 절차를 준비한다.

-결핵이 의심되었다 하더라도 정확한 진단을 위해 3회의 걸쳐 객담을 받아 AFB Stain 검사를 실시한다. 다만 AFB Stain 검사는 배양검사 특성상 2~8주 후에 검사 결과가 나오므로 신속한 진단을 위해 Tb-PCR(분자생물학적 검사)를 실시할 수 있다.

-결핵 환자가 입원한 병실은 7.4 환자치료영역 환경관리 규정에 따라 격리실로 간주하여 청소 및 소독을 시행한다.

가. 결핵 유행 시 조치

-결핵 유행 시 면회객을 제한하며 7.7 감염성 질환자 관리 규정에 따라 격리실로 간주하고 추가 실내 소독하며 결핵 예방 및 전파 방지를 위하여 추가 교육을 실시한다.

3.2.1 심폐소생술 관리

조사부서	전 직원
조사방법	질문, 자료확인

1. CPR의 적용범위

-심폐소생술이 필요한 환자 발생 시 환자인식밴드 등을 확인하여 'DNR' 스티커 부착 여부를 확인한다.
-DNR 환자는 EMR 메모창에 DNR로 기록한다.

2. 심폐소생술의 절차

가. 서면 DNR 동의서를 작성하지 않은 모든 대상자는 심정지 상황 시 심폐소생술에 동의한 것으로 간주한다.

나. 비상체계 활성화 방법(원내방송 요청)

-원내번호 900번(원무과)으로 즉시 전화하여 응급 비상방송(코드블루) 의뢰
※ 약속멘트 : "CPR+발생장소"순으로 2회 방송
-진료시간 이외(야간 및 공휴일)에는 유선으로 당직의사에게 알린다
-간호인력(간호사, 간호조무사)은 다수가 수행하므로 도착순으로 간호사와 간호조무사를 간호인력 1, 간호인력 2, 그 외 간호인력으로 구분한다.

역할 분담	의사	한의사	간호인력1	간호인력2	그 외 간호인력
팀 리더	O	O	X	X	의사 및 간호 인력 1, 2의 지시하에 수행한다.
의약품, 검사처방	O	X	X	X	
환자상태감시(의식상태)	O	O	O	O	
흉부압박	O	O	O	O	
인공호흡(Bag mask)	O	O	O	O	
기관내삽관	O	X	X	X	
자동제세동(AED)	O	O	O	O	
CPR관련 구두/전화 처방 기록	O	O	O	X	
투약	O	X	O	X	
물품조달	O	O	O	O	

다. 초기 대응 체계

-기본 심폐소생술 : 최초 심정지 환자 발견 시 발견자는 심폐소생술 팀 구성 전까지 기본 심폐소생술을 시행한다.

발견자 초기대응 (표준 심폐소생술)		가슴압박 심장마사지 실시 (속도 : 분당 100-120회 / 깊이 : 5cm)	※비상체계에 따라 심폐소생술 팀이 도착하기 전까지 실시한다.
심폐소생술 팀	C	흉골압박 심장마사지 실시 (횟수 : 30회 / 속도 : 분당 100-120회 / 깊이 : 5cm)	※필요 시 보호구를 착용하며(감염 의심 시 KF94, 보안경, 가운 착용 에 Ambu-bag을 사용한다.
	A	기도의 확보	
	B	Ambu-bag으로 호흡 불어넣기 (인공호흡:2회)	

-자동제세동기(AED)사용 : 사용방법을 숙지하고 있는 모든 직원

3. 심폐소생술 관련 장비 관리

가. AED(자동제세동기)

-입원 및 진료 영역에서는 골든타임 4분 이내 제세동기를 즉시 현장에 도착·적용할 수 있도록 비치·관리한다.
-제세동기 보유 부서는 부속물품 구비 및 항상 충전 여부를 확인하여 언제든지 사용할 수 있도록 관리하여야 한다.
-제세동기 보유 부서는 사용가능 여부 등을 매일 1회 점검표를 이용하여 점검(일상점검) 한다.
-의료기기관리담당자는 외부 업체에 의뢰하여 정기(예방) 점검을 연 1회 시행한다.
-AED는 3 병동, 6병동에 보유 하고 3병동은 1층 ~ 4층 적용하고, 6병동은 5층 ~ 8층 적용한다.

3.2.2 수혈환자 관리

조사부서	진료부, 간호부, 임상병리사
조사방법	질문, 자료확인

1. 혈액제제 보관 및 관리

가. 혈액제제 확인

-3병동 간호사는 수령한 혈액의 혈액백 손상, 표지 파손, 혈액 혼탁, 변색 또는 용혈 여부 확인

-농축적혈구는 1단위로 불출하고 냉장고는 1-6℃ 온도 관리대장아 일/2회 기록

2. 수혈 직전 혈액제제 및 환자확인

가. 병동으로 운반된 혈액은 수혈 전 '두명의 의료인이' 함께 재 확인

-혈액의 양, 색깔, 탁도, 혈액백 파손여부

-교차적합시험 및 적합성 표지 라벨 확인

-의사 수혈 처방 일치 여부 확인

-환자이름, 등록번호, ABO 및 RhD 확인

-수혈 직전 2인의 의료인이 환자 바로옆에서 혈액백 정보와 환자 정보 일치 여부 소리내어 확인

-환자이름, 등록번호 또는 생년월일, ABO 및 RhD 혈액형 비교

3. 수혈시 모니터링 및 부작용 발생 시 대처 방안

-수혈시 부작용 : 발열, 발진, 두드러기, 소양감, 오한, 오심, 그토, 숨이참, 알러지, 흉통 등

-수혈 전, 수혈 시작 시, 수혈 시작 후 15분, 그 후 30분, 1시간 마다, 종료 시 V/S 측정

-수혈 부작용 발생 시 환자안전 사고 보고 체계에 따라 QPS 전담자에게 사고 보고

-특정수혈부작용 발생 시 병원장은 15일 이내 보건소 신고

-원무과장은 혈액감시체계(Biss-BMS)를 활용하여 보고 가능

-이상 증세 호소 시 수혈 즉시 중단, IV 유지 및 담당의 즉시 보고

4. 혈액 폐기

-특별 문제 없이 수혈 완료 시 N/S 500 투여하여 잔여 혈액이 수혈세트에 남지 않도록 한 후 폐기물 박스에 폐기

-수혈도중 부득이 못한 경우 간호기록 및 수혈 혈액 반납/폐기 요청서 작성 후 검체 위탁기관으로 연락하여 폐기 수거 하도록 요청

3.2.3 신체보호대 관리

조사부서	진료부, 간호부
조사방법	질문, 자료확인

1. 신체보호대 사용대상

가. 신체 보호를 하지 않는 경우 자신이나 타인의 안위에 심각한 손상을 초래할 수 있는 환자

-자해 및 타인에게 손상을 입힐 수 있는 경우 중심 정맥관, 도뇨관, 비위관, 기관 삽관 등 각종 생명유지 장치를 자발적으로 제거하려 하거나제거될 가능성이 있는 경우

-과도한 움직임으로 인한 사고 위험이 높은 경우

-그 외 주치의사가 꼭 필요하다고 판단한 경우

2. 신체보호대 사용 전 절차

-환자상태 확인

-신체보호대 사용 전 확인

-신체보호대 사용 처방

-설명 및 동의서 받기

3 신체보호대의 종류 및 제외되는 경우

-종류 : 장갑보호대, 손목 보호대, 발목 보호대

-제외 되는 경우 : 식탁이 달린 의자나 wheel chair, 조끼 억제대, 침상난간

4 신체보호대 사용 처방

-의사는 신체보호대 사용 이유, 방법, 신체부위, 종류 등을 포함하여 1일 1회 처방하며, 처방의 내용이 변경되는 경우 새롭게 처방한다.

-필요시 처방(p.r.n)은 원칙적으로 허용하지 않는다.

5 설명 및 동의서 받기

가. 의료진은 보호대의 적용이 필요한 경우 환자와 보호자에게 설명하여 동의를 구하며 동의서를 작성한다.

-신체보호대를 사용해야 하는 이유

-신체보호대를 대신하여 실시한 방법 및 효과

-신체보호대 사용 부위, 종류 및 방법

-신체보호대 사용 시 발생할 수 있는 부작용, 예방활동 등

나. 인지가 떨어진 환자는 보호자의 동의를 대신 할 수 있고 보호자가 원거리에 위치하여 동의서를 작성하기 어려운 경우는 24시간 이내에 구두 동의를 받을 수 있으며 구두동의는 추후 보호자 내원시 서면동의로 전환한다.(7일 이내)

다. 7일 이내에 보호자가 방문하지 않을 경우 유선으로 구두동의를 재차 확인하고 간호기록지에 기록한 후 보호자를 방문하도록 하여 서면동의로 전환한다.

라. 부위가 변경되거나 중단 후 다시 보호대 적용이 필요한 경우는 동의서를 다시 받는다.

마. 침상 난간의 경우 : 보호자의 동의를 받아 사용여부를 결정하여야 하나, 의료진이 환자의 안전을 고려하여 필요하다고 판단되는 경우는 보호자의 동의 없이도 사용할 수 있다.

바. 단, 휠체어 등 보행·이동 시 낙상방지를 위해 일시 착용하는 안전벨트는 신체보호대가 아닌 단순 낙상예방 보조기구이므로 신체보호대 동의서 징구 대상에서 제외된다. 반면 환자의 신체 부위를 묶어 행동을 제한하는 신체보호대(손발 억제대 등) 적용 시에는 반드시 의사 1일 1회 처방 및 사전 서면 동의서 징구가 필수적이다.

보호자가 상주하지 않는 본원의 특성을 반영한 것이며 일상생활 능력(Activities of Daily Living,ADL)의 감퇴와 인지기능이 감퇴된 환자들을 보다 안전하게 보호하기 위함이다.

6 신체보호대 사용 환자의 관찰 및 기록, 부작용 발생 시 중재

가. 보호대 적용 시 부작용 관찰 기록은 주기적(2시간 마다) 신체보호대 적용 및 관찰 기록지에 보호대 위치변화, 사지말단부위의 맥박, 체온, 피부색, 보호대 위치변화, 혈액순환장애 또는 피부손상위험성 등 관찰 신체보호대 관찰기록지에 기록하여 보호대 사용이 적합 한지를 평가한다.

7 신체보호대 사용 환자의 부작용 예방활동

-허용된 범위에서 움직임이 최대한 가능하도록 한다. 보호대를 사용할 경우 이중 보호를 하지 않으며, 한쪽 팔만 보호할 필요가 있을 때 전신을 보호하지 않도록 한다.
-보호대를 침대에 고정할 경우 침상난간이 아닌 침대 틀에 고정한다.
-피부손상 예방을 위해 뼈 돌출 부위에는 패드를 댄다.
-보호대 사용 시 순환장애를 예방할 수 있도록 한다(손가락 두 개가 들어갈 정도의 공간 확보).
-정상적인 해부학적 체위로 보호대를 사용하여 사지가 유지되도록 한다(근육 수축과 근골격계 손상의 가능성을 줄일 수 있다).
-정맥주입관이나 다른 장치(투석환자의 shunt)를 건드리지 않도록 주의한다.
-매 2시간마다 적어도 10~30분간 보호대를 풀어놓는다.
-매 2시간마다 체위변경을 시행하여 신체보호대로 인하여 욕창이 발생하는 것을 방지한다.
-능동적 / 수동적 관절가동 범위 운동을 취해준다.
-응급상황 발생 시 손쉬운 방법으로 풀 수 있도록 보호대를 고정한다.
-부작용 발생 시 즉각 보호대를 해제하고 의사에게 보고 후 지속 관찰한다.

8. 신체보호대 사용 중단

가. 사용 중단 기준

-신체보호대의 사용 사유가 해소된 경우
-신체보호대를 대신하여 사용할 수 있는 다른 효과적인 방법이 있는 경우
-신체보호대의 사용으로 인하여 환자에게 부작용이 발생한 경우

4.1 의약품 선정

조사부서	진료부, 약국
조사방법	질문, 자료확인

1. 신규 의약품 선정

-신규의약품을 사용하고자 하는 담당의사는 신약(긴급)의약품 신청서를 작성하여 약국에 제출한다.

-제출된 신약신청서는 약물위원회에 상정한다.

-약물위원회에서는 신약에 대해 적응증, 안전성 및 유효성, 경제성에 대해 검토하여 심의한다.

-최근 6개월간 사용량이 미비한 소모부진의약품에 대한 사항도 검토한다.

-긴급사용이 필요한 경우 긴급으로 신청서를 작성하여 결재를 득한 후, 구매하여 사용하고 차기 약물위원회에서 사용에 대해 승인한다.

2. 의약품 정보 제공

가. 신약정보 제공

- 신규의약품이 원내 도입되면 약사는 원내 공지문 통해 정보를 공유한다.
- 최신 의약품 정보의 정기적 갱신을 위하여 정보를 연 1회 업데이트 한다.

3. 의약품 확보 절차

가. 재고가 없는 경우

- **약제과에서는 재고가 없는 의약품의 대체 의약품을 유선, 원내 공지문을 통해 의료진에게 알린다.**
- **약국에 재고가 없는 약에 대한 재고량, 사유, 대체 의약품에 대한 내용을 공지문을 통해 공유한다.**
- **취급하지 않은 의약품이 필요한 경우 신규(긴급)의약품 신청서 작성하여 구매하고 일상적인 공급이 불가능한 상황 시 약사는 원내 대체 의약품의 정보를 제공하고 의약품이 일시 품절일 경우 공급처로부터 품절예정기간 및 공급시기와 원내 대체 의약품에 관한 정보를 정보 제공지로 공유하여 알린다.**

4.2 의약품 보관

조사부서	간호부, 약국
조사방법	질문, 자료확인

1. 약물의 보관

-냉장보관 : 2~8℃
-상온보관 : 15~25℃
-실온보관 : 1~30℃

2. 의약품 보관 상태의 정기 감사

가. 점검 기준

-의약품의 목록 및 수량 일치여부, 유효기간, 보관 방법(냉장, 차광등)준수를 점검한다.
-고위험 의약품의 보관상태, 비상 마약류의 보관 및 관리대장을 점검한다.
-감사 결과에 따라 유효기간 임박 의약품, 변질, 불량 및 파손된 의약품은 병동에서 약국으로 회수 조치한다.

나. 약제과

-약제과에 보유 중인 모든 의약품은 분기별 1회 경구제, 외용제, 주사제로 분류하여 재고수량 확인하고 의약품 보관 상태는 라벨링 손상된 약은 없는지, 의약품 보관장에 지정된 자리에 보관됐는지 분기별로 확인한다.
-약사는 분기별(3,6,9,12월) 임박 유효기간(3개월 이내) 의약품을 관리하며 소진하지 못한 경우 폐기하며 의약품 폐기관리대장에 기록한다.

다. 사용부서

-비치 의약품 목록 및 수량, 유효기간, 보관방법 준수에 대해 해당부서에서 매일 일일 점검한다.
-약사와 병동 간호사는 분기별로 점검하고 경구제는 점검시 마다 교체하며, 주사제는 유효기간으로부터 15일 이내 의약품 이거나 유효기간 경과된 의약품 의약품은 약사가 회수하여 제공한다.

3. 고위험 의약품 보관 및 관리

-고위험 의약품의 범위로는 중등도 진정 의약품, 항암제, 고농도 전해질 제제, 주사용 항혈전제, 주사용 인슐린 제제, 신경근차단제, 조영제 등으로 해당 의약품 중 원내에 사용하고 있는 고위험 의약품은 약물위원회에서 매년 1회 목록을 관리한다.

-병동에서 고위험 의약품을 비치하고 있을 경우 목록을 관리한다.

-고위험의약품으로 지정한 의약품은 지침에 따라 다른 의약품과 분리보관 및 '고위험의약품' 표시하고 유효기간을 관리하여 보관한다.

-주사용 고농축 전해질은 비치 의약품으로 보관하지 않는 것을 기본 원칙으로 하며, 부서의 임상적 특성상 부득이하게 비치가 필요한 경우 '고위험 의약품 반드시 희석 후 사용'이라는 경고문을 보관 장소에 부착한다.

-개봉한 의약품은 지침에 따라 즉시 폐기한다.

-개봉한 의약품 중 폐기하지 않고 보관하는 경우 의약품명, 개봉일자, 폐기일자(유효기간) 포함하여 라벨링 후 보관한다.

7. 의약품 보관 및 라벨링

의약품 종류		유효기간 라벨링
경구약	시럽제	개봉의약품: 개봉일로부터 6개월 소분의약품: 소분일로부터 1개월
	건조시럽	의약품 사용 설명서에 따라
	정제조제	조제일로부터 1년간 (비치의약품 포함)
	산제조제	분쇄, 소분 조제일로부터 6개월간
외용약	외용연고	개봉의약품: 개봉일로부터 6개월간 소분의약품: 소분일로부터 30일간
	튜브형젤	개봉일로부터 6개월간
	안약/ 안연고	개봉일로부터 28일간
주사	인슐린류	개봉일로부터 28일간
	헤파린류	사용 후 즉시 폐기

4.3 처방 및 조제

조사부서	진료부, 간호부, 약국
조사방법	질문, 자료확인

1. 처방 전 감사 내용

가. 처방전 형식감사 : 의료법 시행규칙에 따른 기재사항

-의약품 명칭, 용법, 용량, 빈도, 투여경로(복용법)의 적절성, 처방 일수의 적절성

-성별과 연령에 따른 처방된 의약품의 적절성 : 환자의 나이, 특정 연령대 투여 금기, 체중 및검사결과 등 확인

-중복처방 여부

-의약품 간, 의약품과 음식물의 상호작용

-알레르기 또는 과민반응의 가능성

-병용금기

-의약품간의 상가, 상승, 길항작용

-배합변화 또는 배합불가

-투여기간이 제한되어 있는 의약품 여부

나. 의학적 및 약학적 지식을 바탕으로 검토할 내용

다. 고주의성 의약품이 처방되는 경우 재확인

라. 산제처방의 경우 산제처방의 적합성 확인

-동일성분의 산제 가능 제형 또는 액제가 있는 경우 처방의 정정을 유도한다.

-동일성분 의약품으로 산제 가능한 제형이 원내에 없을 경우 같은 계열의 산제 가능한 의약품으로 처방정정을 유도한다.

-같은 계열의 산제 가능 의약품이 없을 경우, 동일 또는 유사한 적응증, 효능 효과를 가진 산제 가능 의약품으로 처방을 유도한다.

마. 기타 검토사항

-단위 용량(mg, g등)

-복수의 제형 등

바. 감사시점

-조제전 처방을 감사한다.

2. 처방 감사 결과 검토 절차 위험한 결과 예상되는 처방의 중재가 실패한 경우 대처방안

가. 처방 감사 결과에 대해 처방의사에게 검토하는 절차

-처방에 의문사항이 있을 때는 처방의사에게 내용을 확인하고 처방전 감사 기록부에 기재한다.

-처방의사에게 확인안되는 경우 안전한 처방 절차에 따른다.

나. 위험한 결과가 예상되는 처방의 중재가 실패한 경우 대처방안

-처방 감사 결과 위험한 결과가 예상되어 중재를 수행하였으나 중재가 받아들여지지 않은 경우 약사는 병원장에게 보고하고 의약품을 처방한 담당의사는 의견을 조율 하여 처방을 변경 하는 등 조취를 취한다.

3. 조제 후 감사

-수행자 : 조제 후 의약품 가사는 감사업무 수행을 위해 교육받은 약사가 수행하며 약사 부재 시 의사가 수행한다.
-감사시점 : 조제된 약이 외래투약이나 병동으로 불출되기 전에 시행
-조제전 감사요소와 동일한 내용을 감사, 산제 조제 감사 시 이물혼입여부 및 균등분포, 변색 등을 확인
-조제약품의 변색, 혼탁, 입자상 물질 등의 생성여부 등을 확인, 오염여부가 확인되면 약품 반납·폐기

4. 처방 및 처방전의 구성요소

-처방일자와 시간
-약품명 : 원내에서는 상품명을 사용한다.
-투여량과 단위
-투여 경로
-Infusion 약품의 희석액, 희석농도 및 투여속도
-투여 간격 – 특히 PRN 처방은 투여시간 간격과 투여증상을 기재
-의사의 서명
-체중 – 체중에 의해 용량이 결정되는 약품(항암제 등) 등 필요 시
-Tapering/Titrating 처방 – 환자의 검사결과나 환자상태에 따른 약품이나 용량 조정 필요 시 그 기준과 약품명 또는 조정이 필요한 용량 기재

5. 조제

가. 직원 위생 및 안전관리

-조제 전· 후에는 손 위생을 수행한다.
-손 위생은 손 위생 규정에 따른다.
- 일회용 장갑을 착용한다.

나. 조제실 환경관리

-조제실은 관계자 외 출입을 통제한다.
-조제실 내부를 구획하여 위생적이고 청결 상태가 유지(물기 등 오염 유발 요인 제거 등)될 수 있도록 관리한다.
-적절한 환기시설(가루약 조제구역의 집진 장비설치)을 유지 및 관리한다.
-업무 시작과 업무 종료 시에 환경을 점검하고 정기적으로 청소를 실시한다.

4.4 투약 및 모니터링

조사부서	진료부, 간호부, 약국
조사방법	질문, 자료확인

1. 고위험의약품 투여 시 주의사항 및 부작용 발생 시 대처방안

가. 고위험 의약품 목록 : 고농도 전해질, 인슐린 주사제, 헤파린 주사제

나. 의약품 특성과 오류예방을 줄이기 위해 의약품 주입기(Dosi)사용 시 지속적 주입상태, 정확한 용량 투여를 확인하고 간호기록한다.

나. 사용 시 주의사항, 주의관찰사항, 부작용 발생 시 대처방안

-고위험 의약품 별 주의관찰 사항 및 부작용 발생 시 대처방법

구 분		주의관찰 및 부작용 발생 시 대처방법		
		부작용	주의관찰	대처방법
고농도 전해질	KCl	부정맥	호흡이상, 의식저하 여부	-즉시 주입중단 -의사보고 -응급처치
		심정지	의식저하 여부	
		정맥염	주사부위 통증, 발적	
	Nacl	심부전	호흡곤란	
		고나트륨혈증 쇼크	의식저하	
인슐린		저혈당 (50mg/dl 이하)	땀흘림, 불안, 손떨림, 구역질, 어지럼증, 두통, 기면상태, 어눌한 말투	<의식이 있는 경우> 즉시 당을 먹인다.(예 : 과일주스, 요구르트 한 개 이상) <의식이 없는 경우> 고농도 포도당용액 IV
헤파린		출혈	코피, 혈뇨, 혈변 등의 출혈, 소견	-즉시 주입중단 -의사보고 -응급처치

2. 의약품 부작용 보고 절차

가. 원내 보고

-간호사는 의약품으로 인해 의심되는 환자 반응이 발견되는 즉시 담당의사에게 알리고 환자안전 사고 보고서를 작성하여 QPS전담자에게 제출한다.

-의사는 의약품 처방과 투여의약품을 확인하고 약사의 협조를 받아 관련의약품의 인과관계를 조사하여 QPS위원회 및 병원장에게 보고한다.

-담당의는 약사의 의견을 포함하여 약물이상 반응에 대해 최종 인과성을 평가하여 의약품 투여 계획 재수립

나. 원외보고

-의약품 부작용 이 발생 했을 경우 약사법 제 68조의 8(부작용 등의 보고)에 의거하여 병원장은 의약품안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr/)나 지역의약품안전센터(삼성서울병원)을 통해 보고한다.

5.1 환자권리존중

조사부서	전 직원
조사방법	질문, 자료 확인, 게시물 확인

1. 환자의 권리(전직원 숙지)

가. 진료 받을 권리

나. 알권리 및 자기결정권

다. 비밀을 보호받을 권리

라. 상담· 조정을 신청할 권리

2. 환자의 의무(전직원 숙지)

가. 의료인에 대한 신뢰· 존중의 의무

나. 부정한 방법으로 진료를 받지 않을 경우

3. 환자의 개인정보 보호

-환자의 진료정보와 관련된 내용은 타인에게 누설하지 않는다.

-공개적인 장소에서 환자의 신상정보나 진료내용과 관련하여 대화를 나누지 않는다.

-공개된 장소나 모니터에 환자의 이름을 제외한 신상정보나, 진료정보가 노출되지 않도록 한다.

-환자의 주민등록번호 는 뒷자리를 표기 하지 않는다.

-진료내용의 녹음이나 촬영은 사전에 환자의 동의를 얻어야 한다.

-EMR을 사용하지 않거나 PC 자리에서 직원이 부재중일 경우 EMR을 로그아웃한다.

-화면 보호기 등을 설정하여 환자의 개인정보를 보호한다

-진료실 내 동반 가능 보호자만 입실할수 있도록 게시물을 통해 안내한다.

4. 환자의 권리와 의무에 대한 공지

-병동 : 병동 입원 시 담당 간호사는 모든 입원환자에게 입원생활 안내문을 이용하여 “환자권리와 의무”에 대한 내용을 안내하며, 병동 주 출입구, 병실 게시판 등에 게시한다.

-외래 및 기타부서 : 병원 주출입구, 원무과 게시판, 게시판, 공지하여 환자, 보호자 직원 등이 쉽게 알 수 있도록 한다.

5.2 취약환자 권리보호

조사부서	전 직원
조사방법	질문, 자료 확인, 게시물 확인

1. 취약환자의 정의

- 학대(노인,아동) 및 폭력(성폭력, 가정폭력)피해자, 장애환자, 의사소통이 어려운 환자 등으로 각 관련법에 근거.

2. 의사소통이 어려운 환자 지원체계

취약환자	지원부서 및 전화번호	관계기관 및 전화번호
의사소통이 어려운자 (청각, 언어 장애인)	☞ 주간 : - 원무과-사회복지사 ☎02-575-5114(내선910) ☞ 야간 : - 당직의 ☎(의사 당직근무표 참조)	손말이음(107) https://107.relaycall.or.kr
		강남장애인복지관 강남구수어통역센터 1)영상전화:070-7947-0036 010-4131-6798 2)사무실전화:02-451-6798
		서울특별시 시각장애인복지관 02-422-8108
외국인 환자		BBB통역센터(1588-5644)

3. 학대(노인학대 등) 및 폭력피해자(피해자, 가정폭력 등) 발생시 대응 체계

- 아동학대 신고절차

아동학대 범죄를 알게된 경우 주간에는 사회복지사, 야간 및 휴일에는 당직의사에게 보고한다. 보고받은 사회복지사 또는 당직의사는 행정부장에게 보고하고, 행정부장은 병원장에게 보고하고 아동보호 전문기관에 전화하거나 112에 신고한다.

- 노인학대 신고절차

노인학대를 알게된 때 주간에는 사회복지사, 야간 및 휴일에는 당직의사에게 보고한다. 보고받은 사회복지사 또는 당직의사는 행정부장에게 보고하고, 행정부장은 병원장에게 보고하고 노인보호 전문기관에 전화하거나 112에 신고한다.

-성폭력 신고 절차

19세 미만의 미성년자의 성폭력 사실을 알게 된때 주간에는 사회복지사, 야간 및 휴일에는 당직의사에게 보고한다. 보고받은 사회복지사 또는 당직의사는 행정부장에게 보고하고, 행정부장은 병원장에게 보고하고 112에 신고한다.

-가정폭력 신고절차

가정폭력 범죄를 알게 된 경우 정당한 사유가 없으면 주간에는 사회복지사, 야간 및 휴일에는 당직의사에게 보고한다. 보고받은 사회복지사 또는 당직의사는 행정부장에게 보고하고, 행정부장은 병원장에게 보고하고 112에 신고한다.

유 형	유관기관	연락처
아동학대	서울동남아동보호전문기관	02-474-1391
노인학대	중앙노인보호전문기관	1577-1389(24시간)
	서울특별시남부노인보호전문기관	02-3472-1389
성폭력	한국성폭력상담소	02-338-2890
	서초성폭력상담소	02-599-7606
	서울남부해바라기센터	02-870-1700
가정폭력	동산가정폭력상담소	02-599-7646
	까리따스가정폭력상담소	02-2202-7806
외부 의뢰를 통해 필수검사 및 신체검진이 필요한 경우	삼성서울병원	1599-3114
	건국대학교병원	1588-1533
	서울아산병원	1688-7575

4. 학대 및 폭력 예방 활동

- 환자 피부 상태 관찰
-지표 모니터링 관리
-직원 대상으로 연 1회 노인학대 신고의무자 교육을 실시한다.
-간병 위탁업체는 계약시 의료기관이 요구하는 교육을 듣도로 계약서에 조항으로 넣는다.
-환자 및 보호자가 고용한 개인 간병인에게 안내문을 제공한다.
-환자 및 보호자에게 신고절차를 게시물과 안내문을 배포하여 제공한다.

5.3 불만고충처리

조사부서	전 직원
조사방법	질문, 자료 확인, 게시물 확인

1. 불만 및 고충 접수 방법

-전화접수 : ☎ (02)575-5114(대표전화),070-5150-9327(사회복지사)

-직접 방문 : 원무과, 간호부 접수

-병원 내 고객 소리함 비치

고객소리함 비치 장소	층 별	비고
간호사실 데스크	3병동 ~ 7병동	각 1개
원무과 접수 데스크	1층	1개

2. 불만 및 고충 접수 및 회신절차

가. 불만 및 고충 접수 절차

-접수받은 불만 고충 사항을 사회복지사는 불만 고충 접수 내용의 유형을 분류하고 답변 및 간단한 설명으로 해결 가능한 사안은 사회복지사가 환자 및 보호자에게 즉시 답변하거나 설명한다.

-사회복지사가 아닌 불만 고충을 제기 받은 직원은 사회복지사에게 관련 내용을 전달한다.

-사회복지사가 답변할 수 없는 사항일 경우 해당 부서로 통보하여 의견을 요청한다.

-고객 불만 사항을 통보받은 해당부서장은 불만 고충 처리 회신서를 작성하여 사회복지사에게 회신 한다.

-시정 사항을 해당 직원 및 부서장에게 통보하고 필요에 따라 부서 내 개선을 유도하며 관련 직원과 공유한다.

나. 불만 및 고충 회신 절차

-개선 계획 또는 결과를 민원인에게 7일 이내에 전화 또는 직접 설명하여 회신한다.

-회신이 늦어지는 경우 담당자가 중간 회신을 통해 회신이 늦어짐을 안내한다.

-필요시 불만 및 고충 신청자 정보를 보호하기 위해 고객 소리함을 통해 접수가 가능함을 안내하고 연락처를 남기지 않거나 회신을 원치 않은 경우 회신하지 않으며 접수대장에 사유를 남긴다..

-회신 답변은 해당 부서장이 고객에게 전화 또는 직접 설명하는 것을 원칙으로 하되, 해당 부서장이 직접 설명하기 어려운 경우, 부서가 제출한 불만 및 고충처리 회신서를 토대로 사회복지사가 답변할 수 있다.

3. 불만 및 고충처리 절차 안내

-환자 또는 보호자에게 원내 게시판, 입원생활 안내문, 고객소리함 등을 통해 불만 고충 처리 절차를 안내한다.

5.4 의료사회복지체계

조사부서	전 직원
조사방법	질문, 자료 확인, 게시물 확인

1. 의료사회복지체계

-담당부서 : 원무과(사회복지사)

2. 의료사회복지 서비스 의뢰 절차

가. 서비스에 대한 안내(담당부서 및 담당직원)

1) 본원에서 제공하는 의료사회복지 서비스 의뢰 절차에 대해 원내 게시판을 통하여 환자 및 보호자에게 안내하며 안내문에는 담당부서와 담당직원을 포함하여 제공한다.

2) 지역사회기관 담당자 등 타 기관으로부터 상담 요청이 있을 경우에도 절차를 진행한다.

나. 서비스 종류별 절차

1) 환자의 인지 기능 유지 및 향상을 위한 활동 프로그램 서비스

가) 환자의 인지 기능 유지 및 향상을 위한 활동 프로그램의 서비스 참여가 필요한 환자를 위하여 사회복지사는 월별 프로그램 일정표를 각 병동 휴게실 게시판에 공지하고 환자의 자율적 참여를 유도한다.

나) 사회복지사는 환자의 인지기능 및 신체기능 향상이 필요하다고 판단 될 경우 해당 환자를 활동 프로그램의 참여를 유도할 수 있다.

2) 지역사회자원과의 연계 서비스

가) 환자 및 보호자는 지역사회자원과의 연계가 필요한 경우 사회복지사에게 직접 방문하거나 유선상으로 의뢰할 수 있으며 지역사회자원과의 연계에 대한 상담은 방문 상담으로 진행하며 사회복지사는 사회사업상담 대장 및 사회사업 초기 상담일지를 작성한다.

나) 직원은 환자가 지역사회자원과의 연계가 필요하다 판단될 경우 사회복지 협의의뢰서를 작성하여 사회복지사게에 의뢰한다.

다) 사회복지사는 초기 상담 후 지속관리가 필요할 경우 2차 상담을 실시하고 상담일지를 작성한다.

라) 사회복지사는 환자 및 보호자의 의견에 따라 사회사업상담이 종결 되거나 사회복지사가 필요치 않다 판단된 경우 사회사업상담 종결 기록지를 작성한다.

3) 진료비 지원 서비스

가) 환자 및 보호자는 진료비 지원 서비스가 필요한 경우 사회복자사에게 직접 방문하거나 유선상으로 의뢰할 수 있으며 진료비 지원에 대한 상담은 방문 상담으로 진행하며 사회복지사는 사회사업상담 대장 및 사회사업 초기 상담일지를 작성한다.

나) 직원은 환자가 진료비 지원 서비스가 필요하다 판단될 경우 사회복지 협의 의뢰서를 작성하여 사회복지사에게 의뢰한다.

다) 진료비 지원 기준

가) 부약 가족 없는 80세 이상 독거 노인

나) 의료급여 1종, 의료급여 2종 환자 중 진료비 지불이 어려운 환자

다) 위 항목 중 보장성 보험 미가입자 우선 지원

4) 이 외 의료사회복지서비스 의뢰 가능 대상 환자 중 상담이 필요할 경우 사회복지사는 상담을 실시할 수 있다.

다. 의료사회복지 서비스 의뢰 가능 대상

- 인지기능 / 신체기능 유지 및 향상이 필요한 환자
- 진료비 지불에 어려움이 예상되는 환자
- 학대 및 폭력이 의심되는 환자
- 정신적지지 제공이 필요한 말기환자
- 지역사회자원과 연계가 필요한 환자
- 기타 사회복지서비스가 필요한 환자

-의료사회복지 서비스 종류 및 제공 절차, 부서 및 담당자는 게시판 및 안내문을 통하여 게시 및 안내한다.

6.2 환자안전사건 관리

조사부서	QPS전담(담당)자, 전직원
조사방법	질문, 자료 확인

1. 오류의 유형과 환자안전사고 단계별 분류

오류유형	환자안전사고 단계별 분류	
근접오류	Level 0	사건/사고가 일어날 뻔 했으나 우연한 또는 시의 적절한 중재를 통해서 발생이 안됨
	Level 1	사건/사고가 발생했으나 환자에게 해가 없음
위해사건	Level 2	사건/사고의 발생으로 인한 치료 또는 중재를 필요로 함
	Level 3	입원기간이 연장되거나 퇴원 시 장애를 일으키는 사건/사고
적신호사건	Level 4	주요 기능의 영구적 손실을 가져오거나 사망을 초래함

2. 환자안전사고 내부보고체계도

🚨 환자안전사고 내부 보고체계

1. 사고 발견 및 초기 대응

환자안전 사고 발견 시 환자 상태를 확인하고 즉각적인 **응급조치**를 시행합니다.

⬇

2. 즉시 구두 보고

- **일반 사고:** 담당/당직 의사 및 단위 부서장에게 즉시 구두 보고
- **위해/적신호 사건:** **QPS 전담자**에게 즉시 구두 보고 ➡ 병원장 최종 구두 보고

⬇

3. 서류 작성 및 제출

해당 직원이 『**환자안전사고 보고서**』를 작성한 후 **QPS 전담자**에게 제출합니다.

⏱ 사고 유형별 서류 보고 기한 (필독)

근접오류	위해사건	적신호사건
발생일 포함 **5일 이내**	발생일 포함 **5일 이내** (공·휴일 제외)	발생 **24시간 이내** 즉시 (공·휴일 제외)

3. 환자안전사건 발생 시 외부보고



4. 적신호 사건 발생 시 환자 및 보호자에게 관련 정보 제공 절차

-진료과정에서 발생한 내용, 치료계획 등으로 적신호 사건 발생 시 주치의는 환자 및 보호자에게 설명한다.

-적신호사건 발생에 대한 환자 및 보호자에게 진료과정에서 발생한 내용을 자세히 설명한다.

-설명 시에는 발생한 내용 및 조치사항 등에 대해 정확한 사실 정보만을 제공하고 앞으로의 치료계획을 설명한다.

7.2 의료기구 감염관리

조사부서	감염관리실, 간호부
조사방법	질문, 관찰

1. 호흡기 치료기구 감염관리

가. 흡인 시 멸균 카테터 및 생리식염수 관리

-1회용 멸균 카테터를 사용하고 생리식염수 30cc를 사용하여 suction 한다
-흡인배액병은 환자마다 소독된 것으로 교환하며, 한 환자 지속 사용 시 매 근무조 마다 지정된 오물처리실에 오물처리실에서 비우고, 물과 낮은 수준의 소독제로 매 Night 마다 세척, 소독, 건조하여 사용한다.
-흡인병과 연결 된 PVC 흡인 줄은 환자마다 새 것으로 교체하고 한 환자에게 사용시 7일간 사용후 폐기한다.
-Nasal cannula 및 o2 mask는 한 환자에게 사용하며 7일간 사용 후 의료폐기물로 폐기 및 교체 한다. 오염이 보인 경우 즉시 폐기 한다.
-Nebulizer kit 매회 교환한다.

2. 유치 도뇨관 관련 감염관리

-유치 도뇨관 및 소변백은 폐쇄상태를 유지한다.
-소변백은 항상 방광 아래에 위치하도록 하며 꼬이거나 방광으로 역류되지 않도록 한다.
-각 환자마다 별개 수집용기를 사용하며 장기환자인 경우 수집 용기는 매 사용 시 마다 비우고 물 세척하고 낮은 수준 소독제로 매 Night 근무 마다 세척, 소독, 건조하여 사용한다.
-소변 검체 채취 시 도뇨관 고무에 알콜솜으로 닦아 주사기를 사용하여 채취한다.

3. 혈관 내 카테터 관련 감염관리

-말초정맥관 삽입부위를 확인하고 삽입부위에 삽입일자를 기재한다.
-말초부위 카테터 및 수액세트는 72시간마다 교환한다.
-지질제제가 포함된 용액은 24시간 이내 수액세트를 교환하거나 새로운 용액으로 변경 시 마다 교환한다.
-중심정맥관 삽입환자는 발적, 부종, 삼출물 유무 등 삽입부위 확인후 간호기록한다.

7.3 소독 멸균 세탁물 관리

조사부서	감염관리실, 간호부
조사방법	질문, 관찰

1. 소독시설 환경 관리

가. 오염구역과 청결구역은 구획 구분에 따라 작업 동선이 겹치지 않아야 하며 복장을 준수한다.

- 오염구역 복장 : 오염구역 전용 신발, 세척 전용 앞치마 및 장갑

- 청결구역 복장 : 청결구역 전용 신발, 헤어캡

나. 소독실의 온습도는 18~24℃습도는 70% 미만으로 유지한다.

2. 멸균 표지지 관리

가. 멸균 전 검사

- Leak test : 주 1회 멸균기 첫 번째 주기에 시행한다. 1.0mmhg 이하이면 정상이다

- Bowie-Dick test : 매일 첫 멸균 시 마다 test package를 이용하여 시행한다.

나. 멸균 후 검사

- 기계적/물리적 확인(MI) : 멸균 과정 동안 진공, 압력, 시간, 온도를 측정한다.

- 화학적 표지자(CI) : 내부용, 외부용 화학적 표지자를 기구 단위 마다 부착한다.

- 생물학적 표지자(BI) : 주 1회(월) 대조군, 비교군 시약을 사용하여 시행한다.

3. 효과측정 판정 결과에 따른 관리

가. 멸균과정에 문제가 발생한 경우, 멸균기 사용을 중지하고 멸균기 수리를 의뢰하며 해당시간의 멸균물품을 회수하고 기록한다.

나. 기계적/물리적 확인 결과 멸균기 이상 시 멸균기의 사용을 중지하고 멸균기 수리를 의뢰한다.

나. 생물학적 확인에 문제가 발생한 경우

-BI 검사 결과 1회 양성이어도 CI, MI에 문제가 없다면 당장 회수 하지 않으나 이식물 멸균제품은 회수하여 재멸균하고 다시 BI 문제인 경우 멸균기 점검을 시행한다. 회수 할 경우 회수기록대장에 기록한다.

4. 의료기관 세탁물의 정의

가. 의료기관 세탁물

의료기관에 종사하는 자와 진료받는 환자가 사용하는 것으로서 세탁과정을 거쳐 재사용할 수 있는 세탁물

- 침구류 : 이불, 담요, 시트, 베개, 베갯잇 등
- 의류 : 환자복, 가운 등
- 린넨류 : 소독포, 그 밖의 린넨류
- 기타 : 커튼, 씌우개류, 수거자루 등

나. 오염세탁물

의료기관 세탁물 중에서 감염성 물질에 오염되었거나 오염될 우려가 있는 세탁물

-[감염병예방법]에 따른 감염병 환자가 사용한 세탁물과 감염성 병원균에 오염될 우려가 있는 세탁물

-환자의 피, 고름, 배설물, 분비물 등에 오염되었거나 오염의 우려가 있는 세탁물

-동물실험 시 감염증에 걸린 동물의 배설물 또는 분비물에 오염된 세탁물

-그 밖에 감염성 병원균에 오염된 세탁물

다. 기타세탁물

-의료기관 세탁물 중에서 오염세탁물 외의 세탁물

라. 일반세탁물

-의료기관 세탁물 외의 세탁물(환자와 직접 접촉하지 않는 부서의 근무복-예: 원무과)

5. 세탁물 수집

-세탁물 수집 장소는 다른 시설과 구획된 장소를 사용한다.

-세탁물 수집자루는 세탁과 소독이 쉬운 구조이어야 하고, 오염세탁물 수집자루는 기타세탁물과 구분이 가능하도록 붉은색 수집 자루, 사용부서에 따라 검은색 비닐봉지를 사용하여 수거한다.

-병동 외 사용부서는 오염세탁물을 수집할 경우 비닐봉지를 오염세탁물 수집함에 씌워 수집한다.

-세탁물이 혈액이나 분비물 등으로 젖어 있을 때는 혈액이나 분비물 등이 새지 아니하는 비닐봉지에 담아 오염세탁물 수집용기에 넣는다. 젖어 있는 세탁물을 다룰 때는 일회용 장갑을 착용한다.

-세탁물 수집 장소에는 누구나 쉽게 알 수 있도록 세탁물의 분류방법 등을 게시한다.

-오염 세탁물 수집용기는 뚜껑이 있는 용기를 사용하며, 사용할 때를 제외하고 항상 뚜껑을 닫아 둔다.

-최종 세탁물 수거 장소는 환경소독제를 사용하여 주 2회 청소 및 소독을 실시한다.

7.4 환경관리

조사부서	시설관리, 간호부, 감염관리실
조사방법	질문, 관찰, 자료확인

1. 소독제 관리

가. 소독제는 외부로부터 오염되는 것을 방지하기 위해서 제품 용기 그대로 사용 하는 것을 원칙으로 하되 다른용기에 소분하여 보충하거나 또는 재사용하는 용기의 경우에는 완전히 비워지면 보충하고 보충전에 반드시 세척, 건조 시켜야 한다.

나. 소독제를 소분하여 보충한 용기에는 소독제 제품명과 소분일, 유효기간을 라벨링한다.

다. 소독제를 제품 용기 그대로 사용하는 경우 개봉일, 유효기간을 라벨링하여 관리한다.

라. 소독제의 개봉일로부터의 유효기간은 제조사의 지침에 따라 관리한다.

마. 소독티슈를 사용할 경우 개봉일을 표기하고 개봉일로부터 3개월 이내에 사용한다.

바. 소독액 희석기준: 일상환경소독 락스 100배 희석(500ppm), 혈액·체액오염 락스 10배 희석(5,000ppm). 희석 소독액은 당일 제조하여 24시간 이내 사용(라벨링 필수).

2. 청소 및 소독용구 관리

가. 직원은 청소 및 소독 시 구역을 구분하여 적절한 청소 및 소독 용구를 사용한다.

나. 청소 카트는 매일 일과 후에 정리 정돈한다.

다. 사용한 걸레는 소독제를 이용하여 세척하고 건조시켜 놓는다.

1) 자루걸레는 매일 세탁하고 100배 희석 락스(500PPM)에 10분 침적 후 헹구어 건조한다.

2) 걸레는 용도에 따라 구별하여 사용한다.

3) 걸레와 장갑은 구분하여 사용한다.

3. 직원의 개인보호구 착용

가. 직원은 청소 및 소독 시 앞치마, 장갑 등 구역을 구분 하여 적절한 보호구를 착용한다.

7.6 급식서비스 감염관리

조사부서	영양팀
조사방법	질문, 관찰, 자료확인

1. 식재료의 구매, 검수 및 보관방법

가. 식재료의 구매 및 검수

-식재료는 규격, 포장(위생)상태, 품질상태, 원산지, 발주량(수량), 소비기한 등을 확인한다.

-납품시마다 품질검사를 실시하고 검수일지에 기록한다.

-냉장, 냉동탑차로 이동되는 경우 냉장제품은 5℃이하, 냉동식품은 –18℃이하의 유지여부를 확인한다.

나. 식재료의 보관 및 관리

-식재료의 유통기한이 보이도록 진열하고 입고순서대로 사용(선입선출)한다.

-보관 장소의 환경관리

1) 식품과 비식품(소모품)을 구분하여 보관한다.
2) 식재료는 정해진 장소에 보관하고, 깨끗한 포장이 유지되도록 하며, 특히 부패·변질되기 쉬운 것은 주의하여 관리한다.
3) 보관 장소의 온도는 15℃~25℃, 습도는 50~60%이하로 유지한다.
4) 검수대는 60cm, 식품보관 선반은 벽과 바닥으로부터 15cm이상 거리를 두고, 직사광선은 피한다.
6) 환풍기를 설치한다.

2. 식재료의 전처리 및 조리

가. 도마와 칼은 용도별로 구분하여 사용한다.

구분 / 색상	도마	칼
빨강	김치류	김치류
파랑	생선용	생선용
녹색	채소용	채소용
노란색	육류용	육류용
흰 색	완제품, 가공품	완제품, 가공품

3. 조리된 식품의 보관 및 배식

-식품을 조리해서 보관할 때에는 반드시 뚜껑이 있는 용기에 넣어 보관한다.

-보존식의 보관 : 매 끼니 식재료 및 완성품을 전용 용기에 각 메뉴별 약 150g 이상 채취하여 -18°C이하의 냉동고에서 144시간(휴무일 구분 없이 7일) 동안 보관하며 완제품인 경우 그대로 보관한다.

-환자식은 뚜껑이 있는 식기와 배식카트를 사용하여 배식한다.

-감염이 높은 환자에게 배식할 때에는 간호 인력의 협조를 얻는다.

4. 조리장 관리

구역명	작업내용	구분
검수구역	각종 식재료 검수	오염구역
전처리구역	각종 식재료 전처리	오염구역
식기세척구역	퇴식 카트 및 식기 세척	오염구역
조리구역	가열 혹은 비가열 조리	청결구역
상차림구역	조리가 완료된 음식을 분배/상차림 하여 배식용 카트에 싣기	청결구역

5. 급식종자사 관리

가. 유증상 직원관리

-소화기계 감염병, 결핵(비감염성인 경우 제외), 피부병 기타 화농성 질환, B형 간염(전염의 우려가 없는 비활동성 간염은 제외)의 질병에 걸린 사람은 급식관련 업무에 근무할 수 없다.

-열이 나거나, 설사, 구토, 구역 등의 증세가 있거나 피부에 배농 병소가 있는 경우에는 즉시 보고하도록 하고 직무제한을 한다.

나. 부상 또는 안전사고 발생 시 원내 직원안전 내규에 따른다.

-베임

1) 출혈이 있는 경우 상처부위에 깨끗한 거즈를 대고 눌러 압박하여 지혈
2) 접수 →진료원장 진료 →치료
3) 밴드 부착 후 고무골무 착용하고 증상에 따라 작업 또는 휴식

-화상

1) 화상 부위를 찬물에 담가 피부의 열을 식힘
2) 접수 →진료원장 진료 →치료
3) 화상연고 도포 후 방수밴드 부착 후 증상에 따라 작업 또는 휴식

-낙상

1) 관절이 삐었을 때 상처부위 고정
2) 접수 →진료원장 진료 →증상에 따라 작업 또는 휴식
3) 압박붕대 감은 후 작업

다. 손을 씻어야 하는 경우

-주방에서 근무를 시작하기 전
-식품재료를 처음 대할 때
-기구나 설비 사용 전
-음식을 만지기 전
-화장실을 이용한 후
-식사와 휴식 후
-얼굴이나 몸을 만지거나 기침을 하거나 코를 푼 후
-병동 배식 시

라. 직원 복장

-조리 및 음식물 취급에 직접 종사하는 직원은 해당 작업에 준하여 위생복과 위생모, 전용작업화를 착용해야 한다.

-조리 및 음식물 취급에 직접 종사하는 직원은 해당 작업에 준하여 장갑, 앞치마, 위생복과 위생모, 전용 작업화를 착용해야 한다.

	복 장	장 갑	앞 치 마	신 발
조 리 시	조리복(남색) /위생모(검정)	미색고무장갑	하얀색비닐	위생 장화
전 처 리	조리복(남색) /위생모(검정)	분홍색고무장갑	분홍색비닐	위생 장화
상 차 림	조리복(흰색) /위생모(검정)	일회용	곤색면	위생 장화
배 식 시	조리복(흰색) /위생모(검정)	일회용	곤색면	위생화
설 거 지	조리복(흰색) /위생모(검정)	적색고무장갑	곤색비닐	위생 장화

7.7 감염성질환 환자관리

조사부서	전 부서 (간호부, 진료부, 감염관리실)
조사방법	질문, 관찰, 자료확인

1. 격리 원칙 및 감염병 격리주의 유형

가. 공기주의 (활동성 결핵, 홍역, 수두 등):
- 본원 음압격리실 부재로 1인실(공조기 차단, 자연환기) 격리 후 상급병원 신속 전원 조치.
- 의료진 및 직원은 병실 출입 시 밀착도 검사를 거친 KF94 마스크 필수 착용.

나. 비말주의 (인플루엔자 등):
- 1인실 격리 또는 코호트 격리하며, 환자와 1m 이내 밀접 접촉 시 외과용 마스크 착용.

다. 접촉주의 (CRE, VRE 등 다제내성균):
- 병실 입구에 접촉주의 표지판 부착 및 전용 혈압계·청진기·체온계 병실 내 비치.
- 병실 출입 시 일회용 가운과 장갑 착용 필수, 환자 접촉 전·후 물과 비누/손소독제 손위생 철저.
- 다제내성균 격리실 환경소독은 락스 대신 전용 소독티슈(고수준 표면소독제)를 사용하여 1일 1회 이상 표면 소독.

라. 격리 해제 기준:
- VRE: 1주일 간격으로 시행한 연속 3회 배양 검사에서 모두 음성 확인 시 주치의 격리해제 처방.

2. 옴(Scabies) 환자 감염관리

가. 의심 즉시 1인실 격리 조치하고 주치의 진단 하에 치료제를 목 이하 전신에 도포.

나. 연고 도포 후 24시간 동안 격리를 엄격히 유지하며, 해당 직원은 대민 접촉 업무에서 배제.

다. 환자가 사용한 침구류 및 의류는 60°C이상의 온수로 세탁하거나 비닐백에 밀봉하여 72시간 이상 격리 보관 후 세탁.

라. 간병 및 간호 처치 직원은 일회용 가운과 장갑 등 개인보호구를 반드시 착용.

3. 개인보호구 착·탈의 순서

가. 착용 순서 : 가운 입기 ➔ 마스크(KF94/외과용) ➔ 보안경(고글) ➔ 장갑 착용

나. 탈의 순서 : 장갑 벗기 ➔ 보안경(고글) 벗기 ➔ 가운 벗기 ➔ 마스크 벗기 ➔ 손위생 실시!

※ 오염된 보호구의 겉면이 신체나 의복에 닿지 않도록 주의하여 의료폐기물 전용용기에 폐기한다.

8.2 의료기관 운영방침

조사부서	전 부서
조사방법	질문, 관찰

1. 미션의 제정

-미션과 비전의 결정은 직원, 환자 및 보호자, 지역사회의 건강증진 등을 고려하고, 병원장의 경영이념을 반영하여 결정한다.

-미션의 수정, 개정 시 전 직원이 참여할 수 있는 공모전, 자료수집 등을 통해 의견을 수렴하여 운영위원회의 심의를 거쳐 병원장이 결정한다.

-미션과 비전의 수정, 개정 절차공모전 공고 →자료 수집 →운영위원회 심의 →이사장 승인 →공표

2. 미션의 공지

가. 미션은 전 직원 및 환자 또는 보호자, 지역사회에 공유할 수 있도록 공지되어야 한다.

나. 미션의 공지방법

-문서 및 내부 게시판

3. 미션의 이해

-직원은 미션이 공지되었는지 알고, 미션을 이행하기 위해 내용을 이해한다.

4. 미션의 이행

-의료기관을 미션을 이행하기 위해 구체적인 활동을 수행하며, 전직원은 미션과 비전을 달성하기 위해 숙지 후, 적극 실천하도록한다.

-병원운영위원회는 중기 또는 장기 목표 및 계획을 수립하고 활동을 실시하며 활동 내용을 평가 진행 하여 병원운영위원회에 보고한다.

5. 전직원 공유 사항

-미션 : 환자의 육체적 질병뿐 아니라 정서적 부분까지 보호자의 마음까지 헤아려 행복을 드리는 병원

-비전 : 환자가 감동하는 병원, 직원이 행복한 병원, 타협하지 않는 최선의 의료서비스를 제공하는 병원

8.3 윤리적 갈등 해결 및 폭력 예방

조사부서	전 직원
조사방법	질문, 자료확인, 관찰

1. 폭력발생 시 대응 절차

가. 대상 (직원, 직원 간 / 환자 및 보호자와 직원 간)

나. 폭력의 정의(폭언, 폭행, 협박, 성폭력, 성희롱, 직장 내 괴롭힘 등)

다. 폭력 예방을 위해 교육 및 홍보(포스터)를 실시한다.

라. 폭력 예방 활동 : 교육 및 홍보

가) 폭력행위 예방 매뉴얼 마련 및 직원 교육

(1) 폭력행위 예방을 위해 매뉴얼을 마련하여 배포한다.

(2) 고객응대근로자의 건강장해 예방을 위해 연 1회 이상 교육을 실시한다.

나) 폭력행위 예방 게시물 제작 및 게시

(1) 폭언 등을 하지 아니하도록 요청하는 문구를 잘 보이는 곳에 게시하거나 또는 음성 안내 실시한다.

(2) 고객응대근로자의 건강장해 예방을 위해 필요한 조치로 직무스트레스 조사를 2년마다 실시하여 직무스트레스의요인을 파악 및 개선하고 직무스트레스가 높은 직원을 대상으로 교육을 실시한다.

2. 폭력 상담 및 신고 절차

1) 폭력 상담 및 신고 절차 안내

다) 직원 대상 폭력 상담 및 신고절차 안내

(1) 고충처리 담당자 : 피해자의 보호를 위해 성별에 따라 담당부서 원무과, 간호부 이며 남자는 원무과장 여자는 간호부장에게 보고한다.

(2) 폭력사고 발생 보고서 양식에 따라 고충처리 담당부서에게 보고한다.

(3) 직원 대상 폭력 상담 및 신고절차는 병원 게시물을 통해 안내 한다.

라) 환자(보호자) 대상 직원에 대한 폭력 발견 시 신고절차 안내

(1) 고충처리 담당자 : 담당부서 원무과, 간호부 이며 남자는 원무과장 여자는 간호부장에게 보고한다.

(2) 폭력(진료방해, 난동) 상황 발생 시 처리 절차에 따른다

(3) 환자(보호자) 대상 직원에 대한 폭력 신고절차는 병원 게시물, 안내문을 통해 안내한다.

3. 진료 관련 윤리적 갈등 해결

1) 윤리적 갈등의 적시 해결을 위한 절차

가) 진료 의사는 생명 존엄성 윤리적인 문제 및 갈등이 발생한 경우 '윤리문제 발생 보고서'를 작성하여 위원회 간사에게 접수한다.

나) 접수된 생명 존엄성 윤리적 사안 및 직원의 윤리적 사안에 대해 위원회 간사는 해당자 및 조사 평가하고 보안하여 회의 시 안건으로 상정한다.

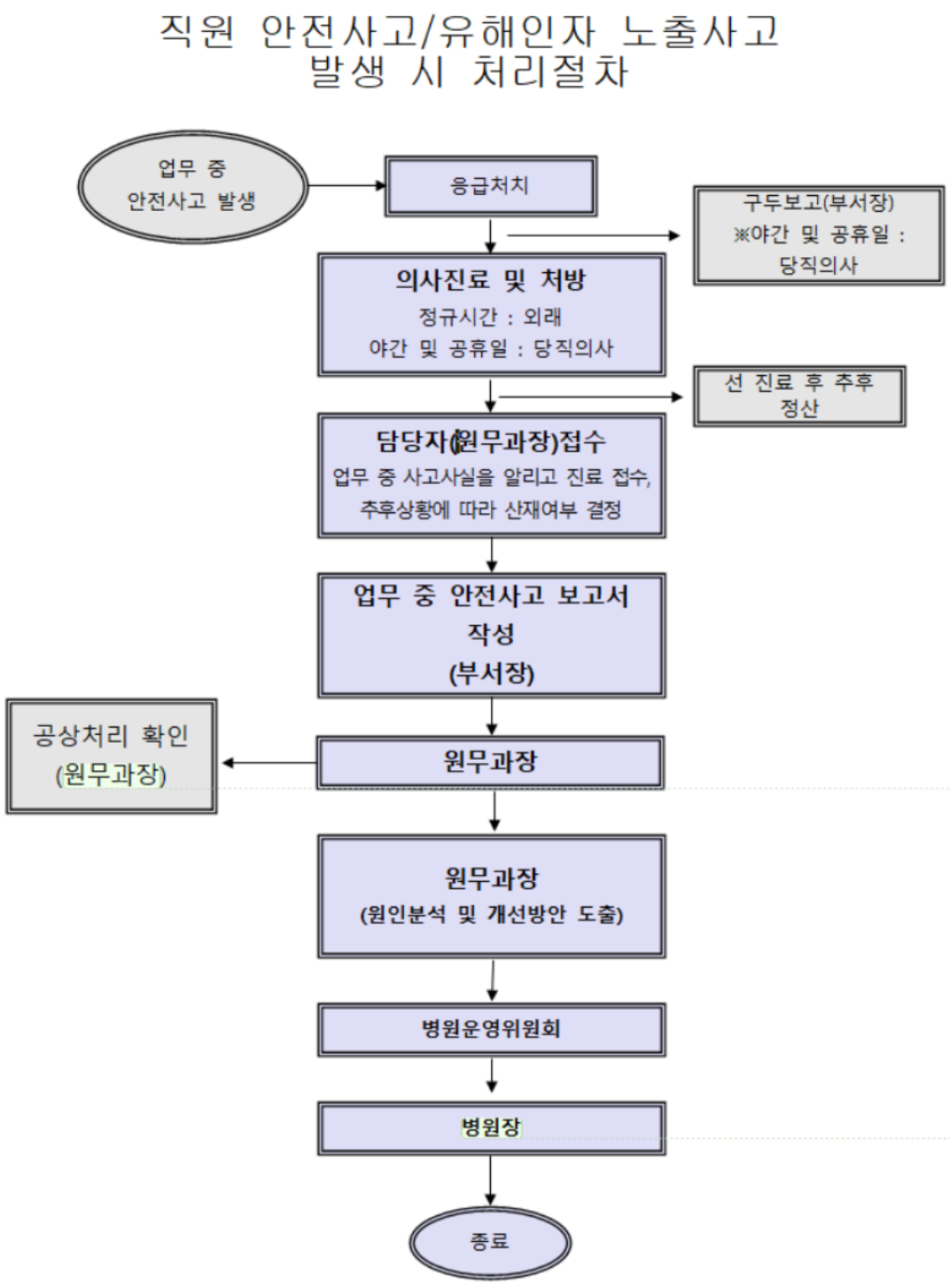
다) 해당 생명 존엄성 및 직원 윤리적 사안에 대한 최종판정을 고지하고, 최종판정에 따른 조치를 취한다.

라) 생명 존엄성 및 윤리적 사안에 대한 심의 및 결론에 관해 최종보고서를 작성하여 병원장에게 제출한다.

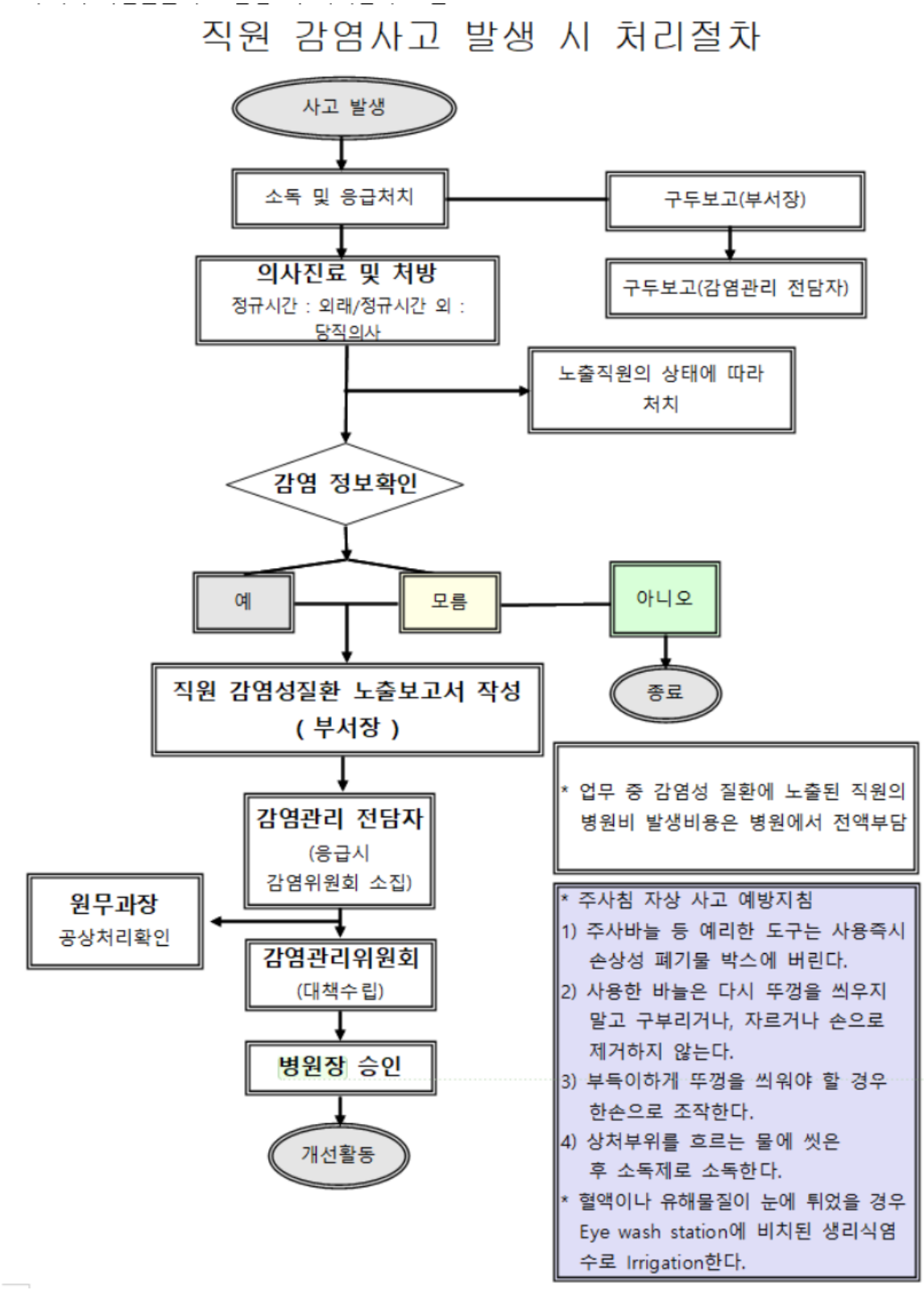
9.4 직원안전 관리활동(필수)

조사부서	보건관리자, 감염관리 전담자, 전 직원
조사방법	질문, 자료확인

1. 직원안전사고 보고 절차



2. 직원감염사고 보고 절차



10.1 시설 및 환경안전 관리

조사부서	전 직원
조사방법	질문, 자료확인, 관찰

1. 시설 안전 사고 보고 절차

시설안전사고 : 정전, 단수, 의료가스 등 각종 기계장치 및 설비 고장으로 인한 사고를 말한다.

병원장		
⇧		
행정부장	⇨	- 안전사고조사, 원인 분석 및 개선활동을 한다. - 병원장에게 보고한다.
⇧		
시설팀장	⇨	- 안전사고 지역을 표시하고 접근근지 등 안전조치를 취한다. - 필요시 유관기관에 지원을 요청한다. - 전기안전사고: 한국전기안전공사(02-410-2600) - 가스안전사고: 한국가스안전공사(1544-4500) - 승강기안전사고: 오티스 1661-6112) - 기타: 상수도사업소(02-3146-4700), 대왕 파출소(02-3411-0323,112), 강남소방서 세곡119센터(02-451-0882)
⇧		
안전사고 최초신고자	⇨	- 신속하게 주위에 사고 사실을 알린다. - 신고 후 작업 중지 및 주변 인원을 안전한 곳으로 대피시킨다.

2. 환경안전 사고 보고 절차

시설물 이외의 원인으로 발생하는 안전사고로 낙상, 미끄러짐, 전도 등의 사고를 말한다.

1. 환자 안전사고: 보고절차, 보고시기 및 방법은 [6.2 환자안전사건 관리] 규정에 따른다.
2. 내원객 안전사고: 내원객 안전사고 발견자는 내원객 안전사고 보고서를 작성하여 시설팀장에게 접수하고 시설팀장은 행정부장에게 보고한다.
3. 보고받은 행정부장은 병원장에게 보고 한다.
4. 직원 안전사고: 보고절차, 보고시기 및 방법은 [9.4 직원안전 관리활동] 규정에 따른다.

10.3 위험물질 관리

조사부서	시설관리, 영양팀
조사방법	질문, 관찰, 자료확인

1. 유해화학물질 신고 및 폐기 절차

가. 유해화학물질 담당자는 유해화학물질의 입출고 시 유해화학물질 취급 관리 대장에 기록한다.

단, 사용부서가 직접 유해화학물질을 발주하여 구매 시 해당 부서가 입출고 관리를 위해 유해화학물질 취급 관리 대장을 기록한다.

나. 유해화학물질 사용부서에서는 사용 시 사용관리대장에 기록하여 관리한다.

- 물질명, 사용량 및 재고량
- 취급일자
- 취급 시 문제점 및 특이사항

다. 유해화학물질 신고(신규등재)

신규 화학물질을 구입할 때는 유해화학물질에 해당되면 등재 신청서를 유해화학물질 담당자(시설팀장)에게 제출하고 담당자는 병원운영위원회 유해화학물질 목록 등재하고 사용부서에 물질안전 보건자료를 비치하도록 한다.

라. 유해화학물질 보관

1) 물질안전 보건자료에 따라 유해화학물질의 안전성을 유지할 수 있는 알맞은 환경에 보관한다.
   (1) 유해화학물질은 별도의 보관 공간에 유해화학물질별로 구분하여 보관한다.
   (2) 보관공간에 경고문 부착 : 보관하는 장소에는 국제적으로 통용되고 있는 조화 시스템의 포스터 중 관련 포스터를 부착한다.
   (3) 유해화학물질 생산 회사의 전용용기를 그대로 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만 다른 용기에 분리 보관하거나 라벨이 없어진 경우 해당 유해화학물질 용기에도 같은 라벨을 부착한다.
   (4) 직사광선은 피하여 보관한다.
   (5) 화기와 열원으로부터 먼 곳에 보관한다.
   (6) 외부 충격에 흔들리거나 떨어지지 않도록 보관한다.
   (7) 위험물질 취급 후에는 반드시 용기 마개를 닫아 밀폐하여 보관한다.
   (8) 지정된 장소에 보관한다.
   (9) 저장장소에는 안전보건표지를 부착한다.
   (10) 작업장에 다량 보관하지 말고 최소량만 보관한다.

마. 유해화학물질 취급

가) 유해화학물질은 지정된 장소에서 보호구를 비치하고 안전보호구를 착용하고 취급한다.
나) 유해화학물질의 독성에 따라 마스크, 가운, 보호안경 등 보호구 착용지침을 준수한다.
다) 유해화학물질은 입에 대거나 냄새를 맡지 않는다.
라) 유해화학물질을 희석할 경우 정해진 물질에만 희석하고 다른 물질과 희석하지 않는다.
마) 물질 취급 후에는 노출된 신체부위는 깨끗하게 씻도록 한다.
바) 신규직원에게 근무시작 전 부서의 물질안전보건자료의 내용을 교육한다.

바. 유해화학물질 노출 시 응급조치 요령

1) 유해화학물질 노출 시 응급조치 후 보건관리자에게 연락하고 진료를 받는다.
2) 눈에 들어갔을 때 Eye Station에서 흐르는 물이나 생리식염수를 이용하여 15이상 세척한다.

사. Spill kit의 구성 및 사용 방법

1) 혈액 및 체액 Spill kit
   가) 구성 : Latex장갑(2켤레), 일회용 마스크(1개), 일회용 가운(1개), 종이타월(1묶음), 보안경(1개),

주황색 의료폐기물 봉지(1장), 희석컵(2개), 락스(1병)

나) 사용방법

- Spill Kit를 가져온다.
- 주황색 의료폐기물 봉지를 벌린 후 개인보호구(마스크, 가운, 장갑)을 착용한다.
- 혈액이나 체액 위에 종이타월을 덮고 종이타월이 충분히 젖도록 소독제를 붓는다.
  (가) 소독제 희석방법
  : 제품 원액 약 5% 기준 물 99mL + 유한락스 1mL = 총 100mL, 약 5,000ppm
  (나) 사용기한: 당일
  (다) 주의: 보호구 착용, 환기, 분무 금지, 산성세제·암모니아·타 세제와 혼합 금지
- 흡수된 종이타월과 장갑을 벗어 주황색 의료폐기물 봉지에 넣는다.
- 주황색 의료폐기물 봉지를 묶어 의료 폐기물 전용용기에 버린다.
- 손위생을 한다.

2) 유해화학물질 Spill Kit

가) 구성 : Latex 장갑(2켤레), 방진 마스크(1개), 신발덮개(1켤레), 일회용 가운(1개), 종이타월(1묶음), 보안경(1개), 지퍼백(1장), Cleansing set(비와 쓰레받기), 유해물질 표시라벨(1장), 주황색 비닐봉지(폐기용 봉투)(1장)

나) 사용방법

- 다른 사람의 접근을 제한하고 주위에 파손 및 오염을 알린다.
- Spill Kit를 가져온다.
- 신발덮개와 가운을 착용 후 보안경, 방진 마스크를 쓰고 마지막으로 라텍스 장갑을 2겹으로 착용한다.
- 파손된 유해화학물질이 액체인 경우 종이타월로 덮고, 분말인 경우에는 종이타월을 물에 적셔 공기 중으로 튀거나 날리지 않도록 조심스럽게 덮은 후 닦아낸다.
- 깨진 유리조각이 있는 경우 Cleansing Set(비와 쓰레받기)를 사용하여 사용한 종이타월과 함께 지퍼백에 담아 밀봉한다.
- 유해화학물질이 엎질러진 영역은 종이타월로 3회 닦아낸 후 깨끗한 물로 닦아낸다.

2. 의료폐기물 운반 방법 및 처분 절차

가. 의료폐기물의 수집 및 운반

1) 의료폐기물을 수거(운반)하는 직원은 감염노출 예방을 위해 보호구(장갑, 마스크, 방수앞치마)를 착용한다.
2) 의료폐기물을 배출함에 있어서는 종류별로 전용용기에 넣어 배출한다.
3) 의료폐기물의 전용용기를 처음 사용 시 파손여부를 확인하고 사용개시일자 및 사용처를 기입하여야 한다.
4) 의료폐기물은 전용 용기에 넣어 밀폐된 상태로 운반하여야 한다.
5) 의료폐기물 전용 운반구는 견고하여야 하며, 소독을 쉽게 할 수 있는 구조로 사용 후 소독하여야 한다.
6) 기도흡인 분비물은 액상 의료폐기물로 합성수지 폐기물 박스에 모아 폐기물 보관소(별도에 보관 장소의) 4°C 냉장고로 분리·운반한다.
7) 사용이 종료된 전용용기는 내부 비닐봉투를 밀봉한 후 외부용기를 밀폐 포장해야하고 밀폐 포장된 상태로 운반하여야 한다. 이때 전용용기는 파손되지 않아야한다.
8) 의료폐기물 운반(이동)시 오염운반카트를 이용하여 운반하며 운반 후 환경소독제로 소독한다. (소독용기 라벨링: 소독제명, 농도, 개시일, 유효기간(24시간))

10.4 보안관리

조사부서	시설관리, 전 직원
조사방법	질문, 관찰, 자료확인

1. 보안사고 발생 시 처리 절차

1. 보안사고 발생 시 처리 절차

가. 도난

1) 신고방법

가) 주간 : 최초 인지자는 시설팀장(☎923)에게 연락한다.

나) 야간 : 최초 인지자는 야간근무자(행정 당직자)(☎900 또는 비상연락망 참조)에 연락 조치 후 관련 내용을 익일에 시설팀장에게 인계한다.

(단, 상황이 긴박하거나 자체통제가 되지 않을 경우 비상연락망을 통한 연락 조치 후 경찰서에 사건을 신고한다.

2) 사고처리 : 시설팀장은 관련된 내용을 사고처리 전에 행정부장에게 보고한 후 지시한 내용을 토대로 사고를 처리한다.

3) 보고 및 재발방지 대책 : 시설팀장은 보안사고 보고서를 작성하여 행정부장에게 보고한 후 향후대책 및 해결방안을 내용을 원내 게시판 공지문을 게시하여 통해 각 부서별로 공유하여 재발을 방지한다.

나. 폭력 및 폭행 등

1) 신고방법

가) 주간 : 최초 목격자는 병원 직원 및 주변 사람에게 도움을 요청하고, 원무과장(☎901)에게 연락한다.

나) 야간 : 최초 인지자는 야간근무자(행정 당직자)(☎900 또는 비상연락망 참조)에 연락 조치 후 관련 내용을 익일에 원무과장에게 인계한다.

2) 사고처리 : 원무과장은 관련된 내용을 사고처리 전에 행정부장에게 보고한 후 지시한 내용을 토대로 사고를 처리한다.

3) 보고 및 재발방지 대책 : 관리과장은 보안사고 보고서를 작성하여 행정부장에게 보고한 후 향후대책 및 해결방안을 내용을 원내 게시판 공지문을 게시하여 각 부서별로 공유하여 재발을 방지한다.

다. 인지저하 환자 무단 외출 등

1) 신고방법

가) 환자의 무단외출 발생 시 목격자 즉시 원무과장에게 연락한다.

나) 원무과장은 전 직원에게 방송을 통해 알리고 발생구역으로 근거리에 있는 근무자를 임시 순찰 투입시키고 유관기관(파출소 등)에 즉시 신고한다.

다) 보호자에게 연락 하여 해당 사실을 알.린다

2) 사고처리

가) 담당 직원의 진술과 목격자 진술, CCTV 모니터링 등을 통해 환자의 이동경로를 파악하며 유관기관(파출소 등)이 출동하면 그 지휘를 받아 적극적으로 협조한다.

3) 보고 및 재발방지 대책 : 원무과장은 보안사고 보고서를 작성하여 행정부장에게 보고한 후 해결방안을 내용을 원내 게시판 공지문을 게시하여 공유하고 재발을 방지한다.

10.6 화재안전 관리활동(필수)

조사부서	전 직원
조사방법	질문, 자료확인, 관찰

1. 소화, 화재통보, 피난 등의 요령

1. 소화, 화재통보, 피난 등의 요령

가. 화재발생 시 행동요령(신고절차 등)

1) 환자(보호(의무)자)의 대처요령은 게시판과 입원생활 안내문을 통하여 안내한다.

2) 원내 화재를 목격한 직원은 "불이야" 외치기만 하여 혼란을 초래하는 행동을 하지 않고, 아래와 같이 대응한다.

3) 행동요령

행 동 요 령	1인 근무	2인 근무	3인 이상
상황전파: "00호실 불났어요", "00호 복도에 불났어요"와 같이 불이 난 곳을 분명하게 알려 불이 없는 곳으로 피난할 수 있도록 한다.	최초 화재발견자	최초 화재발견자	최초 화재발견자
비상연락/경보 가.병원스태프 (간호사 등) : 원무과(내선900)에 화재사실 연락 나.병원스태프 외 (간병사 등) : 발신기 누름스위치를 누른다.	간호사, 간병사	선임간호사, 간병사	선임간호사, 간병사
피난유도 : 간병사에게 피난안내 하도록 요청	간호사	간호사	간호사 A
초기진화: 소규모 화재는 소화기를 들고 바로 진화를 시도한다.	간호사, 간병사	선임간호사, 간병사	간호사 B, 간병사

가) 소화전 사용시에는 화재동류가 유류화재, 전기화재가 아닌지 먼저 확인하고, 부상방지를 위해 되도록 2일 1조로 실시하며, 소방호스 꼬임방지 및 원활한 소화수 공급을 위해 가급적 화재현장 반대쪽 소화전을 이용한다.

나) 화재규모가 클 경우 무리하게 진화를 시도하지 않고 즉시 119에 신고하고, 직원들은 환자들이 모두 안전한 지대로 신속하게 이동할 수 있도록 피난활동에 집중한다.

2. 환자 유형별 대피명단

구 분	환자 상태	대피 상태	대피 우선 순위
C급	독립보행이 가능한 환자	직원의 안내에 따라 계단을 이용하여 안전구획으로 이동	1순위
B급	약간의 도움으로 보행이 가능한 환자, 노약자	직원 또는 보호자의 부축을 받아 계단을 이용하여 안전구획으로 이동	2순위
A급	독립보행이 불가능한 환자, 침상 안정 환자, 휠체어 이용 환자	휠체어, 침대, 시트 끌기 등을 이용하여 우선 옆 구역으로 수평이동 후 안전구획으로 이동	3순위
검사•시술 중 환자	검사 또는 시술 중인 환자	의사의 판단에 따라 검사·시술을 중지하고 안전구획으로 이동	환자 상태에 따라 결정

3. 환자후송계획

-재해 또는 화재로 인한 대량 환자 발생 시 인근 병원으로 후송 처리한다.
-화재로 인한 대피 시 절대로 승강기를 이용하지 않는다.
-피난 시 수액 및 기타 보조기구 등을 생명에 지장이 없는 한 최소한으로 하며 이동이 손쉽게 가능한 도구로 대체한다. (예, 응급산소를 휴대용 산소로 대체한다)
-화재에 기인된 환자(화상환자 등)는 처치 또는 상태에 따라 응급의료정보센터 안내에 따라 이송한다.



4. 소화기 사용방법

가. 소화기 점검주기 : 1회/월

나. 소방교육 : 1회/년

다. 소화기 사용방법

-바람을 등진 상태에서 위치한다.(실내의 경우 출입구를 등지고)
-봉인줄 해제 및 안전핀을 뺀다.
-호스를 잡는다.
-화점을 향하여 손잡이를 힘줘서 누르며 가까운 곳에서 먼 곳으로 비로 쓸 듯이 뿌린다.



5. 소화전 사용법 및 주의사항(2인 1조 – A, B로 지칭)

-A는 소화전을 열어 노즐을 양손으로 꼭 잡고 호스를 빼내어 발화지점까지 간다.
-B는 A가 신호를 보내거나 발화지점을 도착했을 때 밸브를 개방하여 물을 튼다.
-A는 호스 앞부분을 조절하여 발화지점에 물을 분사한다.

6. 전 직원 숙지 사항

-자위소방대 반(본인 반은 기록하세요) :
-자위소방대 업무(본인 업무를 기록하세요) :
-소방교육 일자 : / 소방훈련 일자 :
-화재발생시 대처 요령
-화재대피순서
-소화기 사용법 / 소화전 사용법
-화재 발생 시 집결지

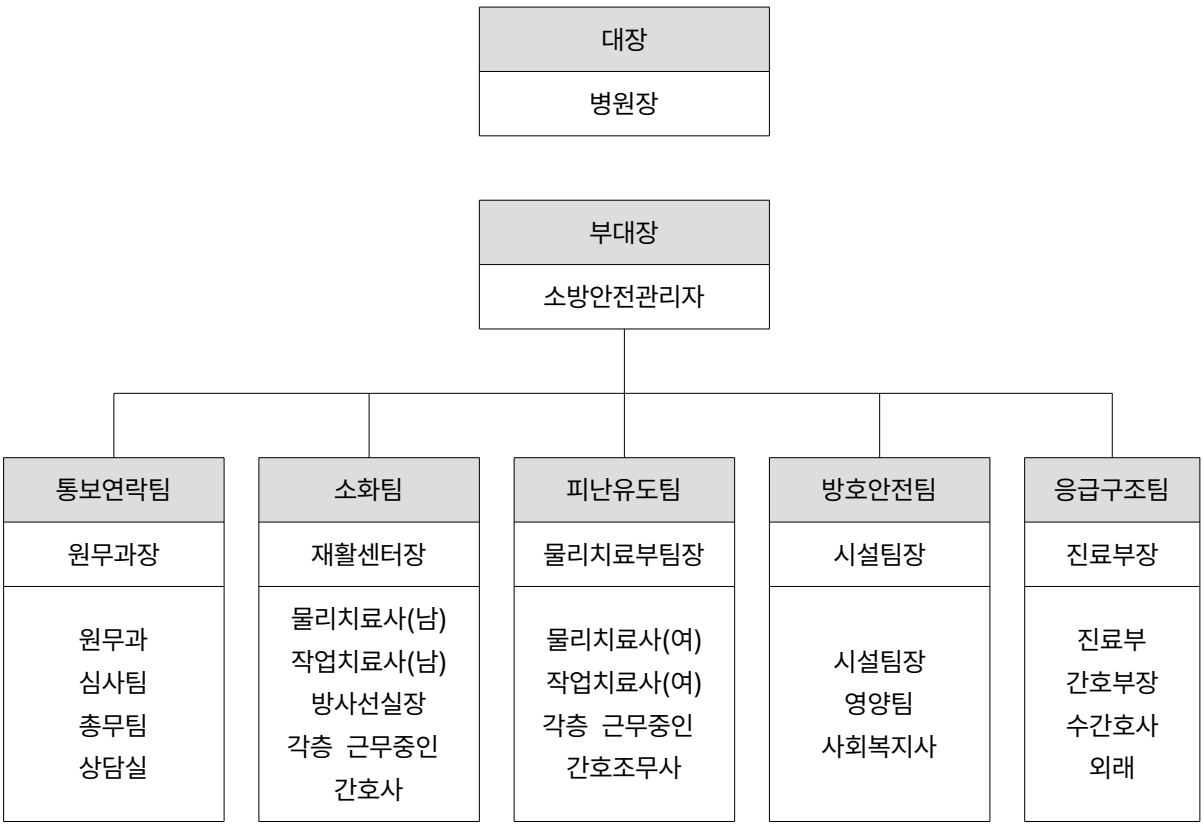
7. 흡연자 발생 시 보고절차(전직원 숙지)

1. 흡연구역은 정문 출입구로부터 좌측 30m 지점을 실외흡연구역으로 지정한다.
2. 흡연구역에는 화재 예방을 위해 방화사(모래)를 비치하여 관리한다.
3. 흡연 구역은 청결상태 등을 일상점검하여 관리한다.
4. 직원은 건물 내부에서 흡연자 발견 시 즉시 제지하고 병원 입구 좌측 30m 실외흡연구역으로 안내한다.
5. 직원의 금연구역에서 흡연 적발 시 발견한 직원은 소속 부서장에게 통보하고 부서장은 흡연 직원에게 경고 및 징계조치를 할 수 있다.
6. 금연구역에서 환자가 흡연시 1차 경고 하고 계속 흡연 시 강제 퇴원 조치 할수 있음을 고지한다.

8. 피난층 설정

위치	피난 층
2층~8층(일반적인 경우)	화재가 발생하지 않은 반대쪽 피난계단을 이용하여 지상1층(피난층) 외부로 대피한다.
2층~8층 (계단실 화염 차단 등 비상시)	화염 발생 층보다 높은 층: 피난계단을 이용하여 9층 옥상으로 대피한다. 화염 발생 층보다 낮은 층 : 피난계단을 이용하여 지상 1층 외부로 대피한다. 양쪽 계단 모두 진입 불가 시 : 각 층 스테이션 우측 [휴게공간(방화스크린 안쪽 공간)]으로 이동하여 연기를 차단하고 소방관 진입창을 통해 구조를 대기한다.
1층	주출입구 및 비상구를 이용하여 즉시 건물 외부로 대피한다.
지하층(B1~B4)	피난계단을 이용하여 지상 1층 외부로 대피한다.

9. 자위소방대 조직도



11.1 의료정보, 의무기록 관리

조사부서	심사팀, 원무과, EMR 사용부서
조사방법	질문, 자료확인, 관찰

1. 의무기록 대출, 열람, 반납 관리 절차

가. 대출, 열람, 반납의 원칙

(1) 적용 범위

(가) 진료용 대출: 진료목적인 경우 전산프로그램으로 자동 대출

(나) 진료용 이외 대출: 진료목적이 아닌 필요한 경우 대출신청서 작성하여 승인 후 대출

(2) 의무기록 대출, 열람 및 반납 기간

(가) 의무기록은 법정의 소환장이나 의료법 및 기타 법령에 의하지 않고는 원외 대출을 할 수 없다.

(나) 의무기록의 원내 열람은 다음의 경우에만 가능하며, 진료에 필요한 경우에 우선적으로 대출한다.

① 외래 진료용: 1일

② 입원 진료용: 입원 기간

③ 진료용 이외: 1일

④ 미비차트 정리: 14일

(3) 대출 및 열람이 필요한 경우 EMR 시스템의 [의무기록 열람 신청] 신청 후 보건의료정보관리사의 승인을 얻어야 하며, EMR 시스템에서 열람되지 않는 종이 의무기록은 심사팀에 비치되어 있는 의무기록 대출/열람 신청서 (직원용)를 작성하여야 한다.

(4) 진료용, 보험청구용, 제증명용의 열람 신청은 즉시 승인한다.

(5) 진료용 목적으로 전산프로그램을 통해 열람 된 의무기록은 업무 종료 시 자동반납 된다.

(6) 진료용 이외 대출 및 열람된 종이 의무기록은 원내에서만 사용 가능하며 열람 승인일로부터 당일 업무 마감 시 까지 보건의료정보관리사에게 반납해야 한다.

(7) EMR로 열람된 전산 의무기록은 열람 승인일 로부터 당일 자정 시간 까지 자동 반납 된다.

2. 금기약어, 금기기호 사용절차

-새로운 금기약어나 금기기호가 필요한 경우 직원은 금기약서 및 금기기호 신청서를 보건의료정보관리사에게 제출하고 제출된 신청서는 병원운영위원회에서 심의 및 결정하고 이를 원내 게시판에 공유한다.

-금기약어 및 금기기호는 진료부 및 병동, 관련부서에 공지하고 컴퓨터에 부착하여 사용하지 않도록 한다.

금기 약어/기호	금지 사유	권장 용어
D/C(discharge)	투약의 중지로 오인	Discharge로 쓴다.
U (unit)	O, four, cc로 오인	Unit로 쓴다
소수점 이하의 0(△.0mg)	단위 불명확	소수점 이하의 (.0)은 생략
μg (microgram)	용량오인	Mcg로 쓴다.

11.3 개인정보 보호 및 보안

조사부서	심사팀
조사방법	질문, 자료확인, 관찰

1. 접근통제구역 지정 및 출입 통제

가. 통제구역

-접근통제구역은 의무기록실로 한다.

-접근통제구역은 통제구역 출입관리대장을 비치하고 출입하려는 자는 출입대장을 기록한다.

-인가된 사람만 출입하도록 별도의 출입증을 제공한다.

-의무기록실 : 보건의료정보관리사

-통제구역을 출입하려는 자는 출입증을 패용하여 출입하여야 한다.

나. 정보시스템 접근 통제

- 바이러스와 같은 유해 소프트웨어로 인한 사고가 발생하지 않도록 보안 프로그램을 설치 및 운영하고 자동 업데이트를 진행토록 설정한다.

다. 접근권한

- 인사담당자로부터 입사, 인사이동, 퇴사 등 인사발령 발생 시 보건의료정보관리사는 접근권한 관리대장에 기록하고 최소한의 범위로만 부여한다.

부록: 조사위원 현장 구두질문 자가점검 리스트

조사부서	전 직원 (직종별 자가점검)
조사방법	질문 확인 후 즉각 구두 답변 가능 여부 점검 (답변 제외, 질문 숙지용)

1. 간호부 (간호사) 핵심 기습 질문 10선

Q1. 구두·전화처방 4단계 절차와 의사 전산입력 완료 시한은 얼마인가요?
Q2. Morse 낙상평가 고위험군 기준 점수와 비정기 재평가를 즉시 시행해야 하는 시점은?
Q3. Braden 욕창평가 고위험군 점수와 9점 이하 초고위험군에게 적용하는 특별 중재는?
Q4. 심정지 환자 발견 시 코드블루 방송 요청 내선번호와 AED 목표 적용 시간은?
Q5. 신체보호대 의사 처방 주기와 상태 관찰 주기, 원거리 보호자 구두동의 전환 시한은?
Q6. 의약품 냉장고 적정 보관 온도와 인슐린 주사제 개봉 후 유효기간은 얼마인가요?
Q7. VRE/CRE 환자 병실 출입 시 착용해야 하는 보호구와 환경소독 방법은 무엇인가요?
Q8. 혈액 또는 체액이 바닥에 쏟아졌을 때 Spill Kit 사용 절차는 어떻게 되나요?
Q9. 화재 발생 시 내선 몇 번으로 통보하며, RACE 행동원칙은 각각 무엇을 의미하나요?
Q10. 수혈 시 혈액백 확인 절차(2인 확인)와 수혈 시작 후 부작용 관찰 주기는?

2. 진료부 (의사 / 한의사) 핵심 기습 질문 4선

Q11. 당직 시 구두처방이 허용되는 예외 사유와 처방 전산입력 법적 기한은?
Q12. 신체보호대 처방 시 필수 기재 항목과 1회 처방의 유효기간은?
Q13. 한방 침술 및 부항 시술 시 1회용 멸균품 사용 원칙과 침훈 발생 시 대처법은?
Q14. 다제내성균(VRE) 환자의 격리 해제 처방 기준(배양검사 횟수 및 주기)은?

3. 영양팀 / 조리실 핵심 기습 질문 4선

Q15. 보존식 채취 대상, 1회 채취 용량(g), 보관 온도 및 보관 시간 기준은?
Q16. 식재료 교차오염 방지를 위한 칼·도마 5가지 색상 구분 기준은?
Q17. 조리 완료 시각으로부터 환자 배식 완료까지의 허용 시간은 몇 시간 이내인가요?
Q18. 조리 종사자에게 설사, 발열 등 감염 증상 발생 시 어떤 조치를 취하나요?

4. 원무 / 행정 / 시설 / 미화 핵심 기습 질문 6선

Q19. 입원 환자 확인 2가지 지표와 환자인식밴드 발급 및 부착 절차는?
Q20. 병동에서 비상방송(코드블루, 화재 등) 요청이 왔을 때 원무과의 방송 절차는?
Q21. 개인정보가 포함된 문서(구두처방 기록지, 차트 사본 등)의 파쇄 폐기 기준은?
Q22. 일상 환경소독 소독액 희석 농도(ppm)와 혈액오염 시 희석 농도 및 유효기간은?
Q23. 소화기 및 옥내소화전 사용 방법(PASS 원칙)을 시연해 보세요.
Q24. 비상발전기 무부하 및 부하운전 점검 주기는 어떻게 되나요?

원내 필수 핵심 수치 요약

조사부서	전 부서
조사방법	인증평가 현장 필수 기준 및 핵심 수치 암기

1. 시간 관리 골든타임 (반드시 외워야 할 시간 수치)

- 구두·전화처방 : 응급처치 후 의사 전산입력 24시간 이내 완료, 확인 후 간호사 기록지 파쇄 폐기 [1.1]
- 환자 초기평가 : 입원 후 24시간 이내 완료 (영양 초기평가는 72시간 이내) [2.2.2]
- 신체보호대 : 최소 2시간마다 상태 관찰 및 기록, 원거리 보호자 구두동의 시 7일 이내 서면 전환 [3.2.3]
- 급식 보존식 : -18℃이하 전용 냉동고에서 144시간(휴무일 포함 7일) 동안 냉동 보관
- 희석 소독액 : 락스 희석액은 당일 제조하여 24시간 이내 사용 원칙 (제조일시 라벨링 부착)

2. 핵심 평가 척도 및 기준치

- Morse 낙상 위험도 : 51점 이상 고위험군 (침상/차트 붉은색 스티커, 진정제·마약류 투여 시 즉시 재평가)
- Braden 욕창 위험도 : 12점 이하 고위험군 (9점 이하 초고위험군은 에어매트리스 필수 + 2시간 체위변경)
- 통증 재평가 종료 : 중재 후(경구 1시간 / 주사 30분) 평가 시행, 2점 이하 도달 시 재평가 종료
- 자동제세동기(AED) : 심정지 환자 발생 시 골든타임 4분 이내 도착 및 현장 적용

3. 온도 및 보관 기준

- 의약품 냉장고 : 2 ~ 8 ℃유지 (매일 2회 점검 및 온도기록부 작성)
- 실온 보관 : 1 ~ 30 ℃/ 상온 보관 : 15 ~ 25 ℃
- 식자재 보관 창고 : 15 ~ 25 ℃(습도 50 ~ 60% 이하 유지)
- 조리 후 배식 완료 : 조리 완료 시각으로부터 2시간 이내 배식 완료

4. 개봉 의약품 유효기간 라벨링 원칙

- 인슐린 주사제 / 점안액(안약) : 개봉일로부터 28일간 (개봉일·폐기예정일 라벨링)
- 시럽제 : 소분의약품은 소분일로부터 1개월(30일) / 원포장 개봉은 6개월간
- 정제(알약) : 조제일로부터 1년간 / 산제(가루약) : 분쇄·소분 조제일로부터 6개월간
- 환경 소독티슈 : 개봉일로부터 3개월간 (개봉일자 라벨링 부착)

5. 비상 연락망 및 필수 내선번호

- 심폐소생술(코드블루) / 화재 비상방송 : 원무과 내선 900번 (야간/휴일: 당직실/010-4297-2770)
- 원내 폭력(코드블랙) : 내선 901번(원무과장) / 원내 도난 : 내선 923번(시설팀장)
- 노인학대 신고전화 : 1577-1389 (노인보호전문기관) 또는 112 (경찰청)

네이처 요양병원
NATURE HOSPITAL

Learn it Solution